

CỘI WELLNESS

Lục Dưỡng

Cơ chế sáu phép dưỡng

Ăn uống · Luyện tập · Thiền · Cảm xúc · Ngủ nghỉ · Môi trường sống

Đông lý · Tây chứng

Bản nháp v0.1 · 04/10/2026

Triển khai từ *Lý luận Lục Dưỡng v0.3*

Tài liệu nội bộ · Chưa thẩm định

Mục lục

1. Lời dẫn

2. Tổng quan sáu trụ

3. Phần 1 · Trụ Ăn uống

- Cách đọc tài liệu
- Cơ chế gốc: Tỳ Vị vận hoá
- A. Ăn gì
- B. Ăn thế nào
- C. Đưa gì khác vào
- Tổng hợp: trụ Ăn uống nuôi bốn tạng
- Ăn uống tác động sang các trụ khác
- Đo lường trụ Ăn uống 📏
- An toàn riêng cho trụ Ăn uống
- Lộ trình tiệm tiến gợi ý 📅

4. Phần 2 · Trụ Luyện tập

- Cách đọc tài liệu
- Cơ chế gốc: động thì khí huyết lưu thông
- A. Động
- B. Bốn phẩm chất của thân
- C. Cách tập
- Tổng hợp: trụ Luyện tập nuôi bốn tạng
- Luyện tập tác động sang các trụ khác
- Đo lường trụ Luyện tập 📏
- An toàn riêng cho trụ Luyện tập
- Lộ trình tiệm tiến gợi ý 📅

5. Phần 3 · Trụ Thiền

- Cách đọc tài liệu
- Cơ chế gốc: tĩnh thì thần tàng
- A. Tam điều
- B. Quán
- C. Cách thực hành
- Tổng hợp: trụ Thiền nuôi bốn tạng
- Thiền tác động sang các trụ khác
- Đo lường trụ Thiền 📏
- An toàn riêng cho trụ Thiền
- Lộ trình tiệm tiến gợi ý 📅

6. Phần 4 · Trụ Cảm xúc

- Cách đọc tài liệu
- Cơ chế gốc: tạng Tâm là chủ, thất tình thái quá mới thành bệnh
- A. Hiểu
- B. Điều
- C. Dưỡng
- Tổng hợp: trụ Cảm xúc nuôi bốn tạng
- Cảm xúc tác động sang các trụ khác
- Đo lường trụ Cảm xúc 📏
- An toàn riêng cho trụ Cảm xúc
- Lộ trình tiệm tiến gợi ý 📅

7. Phần 5 · Trụ Ngủ nghỉ

- Cách đọc tài liệu
- Cơ chế gốc: âm dương giao thì ngủ
- A. Giấc ngủ
- B. Điều kiện để ngủ
- C. Nghỉ
- Tổng hợp: trụ Ngủ nghỉ nuôi bốn tạng
- Ngủ nghỉ tác động sang các trụ khác
- Đo lường trụ Ngủ nghỉ 📏
- An toàn riêng cho trụ Ngủ nghỉ
- Lộ trình tiệm tiến gợi ý 📅

8. Phần 6 · Trụ Môi trường sống

- Cách đọc tài liệu
- Cơ chế gốc: thiên - địa - nhân hợp nhất
- A. Tự nhiên (thiên, địa)
- B. Xã hội (nhân)
- Tổng hợp: trụ Môi trường nuôi bốn tạng
- Môi trường điều chỉnh năm trụ còn lại
- Môi trường tác động sang các trụ khác
- Đo lường trụ Môi trường 📏
- An toàn riêng cho trụ Môi trường
- Lộ trình tiệm tiến gợi ý 📅

Lời dẫn

Bộ tài liệu này triển khai phần **Sáu phép dưỡng** trong *Lý luận Lục Dưỡng v0.3* thành **cơ chế thực hành**: mỗi việc làm hằng ngày tác động đến bốn tầng **Thân · Khí · Tâm · Thần** theo con đường nào, người xưa giải thích ra sao, y học hiện đại xác nhận đến đâu, và web app Cội Wellness đưa vào như thế nào.

Bản nháp v0.1, ngày 04/10/2026. Tài liệu nội bộ, **chưa thẩm định**. Mọi trích dẫn kinh điển cần lượng y đối chiếu nguyên văn. Mọi khuyến nghị, ngưỡng an toàn, cờ đỏ cần bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý lâm sàng duyệt. Các nghiên cứu và số liệu nêu tên chỉ để định hướng, cần kiểm tra lại trước khi trích dẫn công khai. **Lục Dưỡng không chẩn đoán, không chữa bệnh**.

Ký hiệu

Ký hiệu	Nghĩa
	Phần Lục Dưỡng tự hệ thống hoá hoặc vận dụng, không có nguyên văn trong kinh điển. Khi truyền thông, nói "Lục Dưỡng vận dụng"
[C1]	Y học hiện đại xác nhận: có hướng dẫn y khoa hoặc nhiều nghiên cứu vững chắc
[C2]	Cổ truyền, có tương đồng hiện đại: có hiện tượng tương ứng, bằng chứng chưa đủ mạnh hoặc chưa nhất quán
[C3]	Cổ truyền, chưa kiểm chứng: kinh nghiệm, lý luận truyền thống
● ● ● ● ● ●	Mức độ một trụ hoặc cơ chế nuôi một tầng (nhẹ, vừa, mạnh); là giả thuyết khởi đầu

Cấu trúc chung của mỗi trụ

Mọi trụ đều viết theo cùng một khung:

- Cơ chế gốc**: nguyên lý nền của trụ.
- Các cơ chế**, mỗi cơ chế gồm bốn phần: **Đông lý** (kinh điển) · **Tây chứng** (bằng chứng, có cấp) · **Tầng được nuôi** · **Trong app**.
- Tổng hợp** trụ nuôi bốn tầng và **đường nối** sang các trụ khác.
- Đo lường**: check-in hằng ngày, hằng tuần, thang đo định kỳ, và những gì **không đo**.
- An toàn**: cờ đỏ khẩn cấp, cờ đỏ cần đi khám, khoá lời khuyên theo tình trạng.
- Lộ trình tiệm tiến** 6-12 tuần, với hai lối vào theo tầng đang yếu.
- Việc cần hội đồng thẩm định**.

Tổng quan sáu trụ

Sáu trụ, hành chủ đạo và cơ chế

Trụ	Hành	Cơ chế gốc	Các cơ chế
1. Ăn uống	Thổ	Tỳ Vị vận hoá	Ngũ cốc vi dưỡng · Ngũ vị điều hoà · Tứ khí và thể chất · Ẩm thực hữu tiết · Thuận thời · Uống · Tỉu và yên
2. Luyện tập	Mộc	Động thì khí huyết lưu thông	Hộ xu bất đổ · Khí lực · Cân cốt nhục · Nhu và hoà · Trung độ · Thuận thời
3. Thiền	Kim	Tĩnh thì thần tàng	Điều tức · Điều thân · Điều tâm · Quán chiếu · Thiền đời thường · Liều lượng và thời điểm
4. Cảm xúc	Hỏa	Tạng Tâm là chủ, thất tình thái quá mới thành bệnh	Tri tình · Điều tình · Sơ tiết · Hỷ hoà · Tương thân · Định chí
5. Ngủ nghỉ	Thủy	Âm dương giao thì ngủ	Túc miên · Thuận thời · Tâm yên thì ngủ · Vị hoà thì ngủ · Chỗ ngủ yên · Bất vọng tác lao
6. Môi trường sống	Bao trùm	Thiên – địa – nhân hợp nhất	Thuận khí hậu · Thanh khí · Ánh sáng, màn hình · Tĩnh âm · Thiên nhiên, nơi ở · Nhân hoà · Nhịp sống

Tổng cộng **6 cơ chế gốc** và **39 cơ chế**.

Sáu trụ nuôi bốn tầng: đề xuất cập nhật

Bảng trong lý luận v0.3 là giả thuyết khởi đầu. Sau khi phân tích từng cơ chế, bộ tài liệu đề xuất các thay đổi sau (in đậm), **cần hội đồng quyết định**:

Trụ	Thân	Khí	Tâm	Thần	Thay đổi so với v0.3
Ăn uống	●●●	●		●	Thêm Thần ● (qua giấc ngủ)
Luyện tập	●●	●●●	●	●	Thêm Thần ● (qua đạo dẫn, giấc ngủ)
Thiền		●●	●●	●●●	Giữ nguyên
Cảm xúc		●	●●●	●●	Thêm Khí ● (sơ tiết); Thần ● → ●● (định chí)
Ngủ nghỉ	●●●	●●	●	●●●	Khí ● → ●● (nghỉ ngơi hồi phục)
Môi trường	●	●●	●●	●●	Thần ● → ●● (ánh sáng, kết nối, nhịp sống)

Theo lý luận mục IX, trọng số chỉ được thay đổi chính thức dựa trên thử nghiệm cá nhân (bậc 2) hoặc nghiên cứu có đối chứng (bậc 4).

Lời khuyên chủ lực có bằng chứng mạnh [C1]

Đây là những lời khuyên nên được **ưu tiên** trong app vì có bằng chứng mạnh nhất và tác động lớn nhất:

Trụ	Lời khuyên C1
Ăn uống	Giảm mặn (dưới 5 g muối/ngày) · giảm đường, nước ngọt · rau quả ít nhất 400 g/ngày · ăn xong 2-3 giờ trước khi ngủ · ít rượu hơn, không thuốc lá
Luyện tập	Bớt ngồi lâu · 150-300 phút/tuần cường độ vừa · sức cơ ít nhất 2 ngày/tuần · thăng bằng cho người từ 65 tuổi
Thiền	Thiền chánh niệm giảm lo âu, trầm cảm ở mức nhỏ – vừa · MBCT phòng tái phát trầm cảm
Cảm xúc	Hoạt hoá hành vi, CBT cho trầm cảm, lo âu · duy trì kết nối xã hội · vận động cải thiện tâm trạng
Ngủ nghỉ	Ngủ ít nhất 7 giờ · giờ dậy đều · ánh sáng sáng, bóng tối tối · CBT-I cho mất ngủ mạn tính
Môi trường	Phòng nắng nóng, rét đậm · giảm bụi mịn, khói trong nhà · không làm việc quá 55 giờ/tuần · kết nối xã hội

Năm cơ chế xuyên suốt sáu trụ

Một số nguyên lý xuất hiện ở nhiều trụ. Đây là xương sống của bộ tài liệu:

Nguyên lý	Kinh điển	Xuất hiện ở
Trung độ (vừa đủ)	Ngũ lao sở thương · Ấm thực tự bội · Hoa Đà "bất đương sử cực"	Ăn uống (hữu tiết) · Luyện tập (trung độ) · Thiền (liều lượng) · Ngủ nghỉ (cửu ngoạ, bất vọng tác lao)
Thuận thời	Tứ khí điều thần đại luận	Ăn uống · Luyện tập · Thiền · Ngủ nghỉ · Môi trường
Vị bất hoà tắc ngoạ bất an	Nghịch điều luận	Ăn uống ↔ Ngủ nghỉ
Tâm động thì ngũ tạng lay động	Linh Khu "Khẩu vấn"	Cảm xúc · Thiền · Ngủ nghỉ
Cửu thị thương huyết	Tuyên minh ngũ khí	Ngủ nghỉ (màn hình khuya) · Môi trường (ánh sáng, màn hình)

Sơ đồ đường nối giữa các trụ

Từ ↓ / Đến →	Ăn uống	Luyện tập	Thiền	Cảm xúc	Ngủ nghỉ	Môi trường
Ăn uống		Đủ đạm, năng lượng để tập [C1]	Ăn chánh niệm [C2]	Chế độ ăn và tâm trạng [C2]	Bữa tối, cà phê, rượu [C1]	Bữa cơm gia đình [C2]

Từ ↓ / Đến →	Ăn uống	Luyện tập	Thiền	Cảm xúc	Ngủ nghỉ	Môi trường
Luyện tập	Đi bộ sau ăn hạ đường huyết [C2]		Đạo dẫn là thiền động [C2]	Vận động cải thiện tâm trạng [C1]	Vận động giúp ngủ ngon [C1-C2]	Tập nhóm tạo kết nối [C2]
Thiền	Ăn chánh niệm [C2]	Thở, chú tâm khi tập [C2]		Gọi tên, quán chiếu cảm xúc [C2]	Thở chậm dễ ngủ [C2]	Thiền từ bi tăng kết nối [C2]
Cảm xúc	Ăn theo cảm xúc, tư thương Tỳ [C2]	Căng thẳng giảm động lực [C2]			Tâm yên thì ngủ [C1]	Xung đột, kết nối [C1-C2]
Ngủ nghỉ	Thiếu ngủ thêm ngọt béo [C1-C2]	Ngủ đủ thì có sức tập [C1]	Ngủ đủ dễ chú tâm [C2]	Thiếu ngủ cảm xúc dễ bùng nổ [C1]		
Môi trường	Môi trường thực phẩm, văn hoá nhậu [C2]	Khí hậu, AQI đổi bài tập [C1]	Tiếng ồn, không gian [C2]	Thiên nhiên giảm căng thẳng [C2]	Ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ [C1-C2]	

Check-in hằng ngày tổng hợp

Mỗi trụ có bộ câu hỏi riêng; khi gộp lại, app **chỉ hỏi những câu thuộc trọng tâm tuần** của người dùng (pháp tắc tiệm tiến), tổng thời gian dưới 1 phút. Bốn câu check-in bốn tầng luôn có:

Tầng	Câu hỏi (0-10)
Thân	Cơ thể hôm nay khoẻ, nhẹ nhõm đến đâu?
Khí	Năng lượng hôm nay đến đâu?
Tâm	Lòng hôm nay yên đến đâu?
Thần	Đầu óc hôm nay sáng, tập trung đến đâu?

Nguyên tắc chung về an toàn và đạo đức

- Cờ đỏ chạy trước mọi lời khuyên** (pháp tắc Thủ chân). Ý nghĩ tự hại thì dừng mọi nội dung, hiển thị số **115** và đường dây hỗ trợ tâm lý đã được xác minh.
- Không chẩn đoán, không chữa bệnh, không thay thế điều trị.** Nhắc không tự ý ngưng thuốc.
- Không bán, không gợi ý được liệu, thực phẩm chức năng, thuốc ngủ** trong phiên bản đầu.
- Không đếm calo, không đặt mục tiêu cân nặng, không xếp hạng người dùng.**
- Không gộp thành một điểm tổng;** cho phép tắt điểm số; chỉ nói về xu hướng.
- Không cổ vũ chế độ cực đoan:** ăn một loại, nhịn ăn dài ngày, tập kiệt sức, thiền cường độ cao.

7. **Thế tục và tôn trọng:** thiền không truyền giáo; thấp hương được tôn trọng; không phong thủy.
8. **Khả thi và công bằng:** lời khuyên phải làm được với hoàn cảnh thật của người dùng.
9. **Dữ liệu tối thiểu, riêng tư:** nhật ký cảm xúc lưu trên thiết bị; không theo dõi vị trí liên tục; người dùng xem, tải về, xoá được.
10. **App cũng phải dưỡng sinh:** gộp lời nhắc, tôn trọng giờ ngủ, không dùng kỹ thuật gây nghiện.

Phần 1

Trụ Ẩn uống

Hành chủ đạo: Thổ

Cách đọc tài liệu

"Cơ chế" ở đây là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**. Mỗi cơ chế có bốn phần:

- Đông lý**: người xưa giải thích thế nào.
- Tây chứng**: y học hiện đại thấy gì, ở cấp bằng chứng nào.
- Tầng được nuôi**: Thân, Khí, Tâm hay Thần.
- Trong app**: hành vi đo được, lời khuyên, nhắc nhở.

Trụ Ẩn uống có **bảy cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Ăn gì	Chất liệu đưa vào	1. Ngũ cốc vi dưỡng (cấu trúc bữa ăn) · 2. Ngũ vị điều hoà (mặn, ngọt, béo) · 3. Tứ khí và thể chất (hàn nhiệt)
B. Ăn thế nào	Cách ăn	4. Ẩm thực hữu tiết (lượng, tốc độ, chú tâm) · 5. Thuận thời (giờ ăn, bữa tối)
C. Đưa gì khác vào	Chất ngoài thức ăn	6. Uống: nước, trà, cà phê · 7. Tỉu và yên: rượu, thuốc lá

Nền chung cho cả bảy là **cơ chế gốc: Tỳ Vị vận hoá**.

Cơ chế gốc: Tỳ Vị vận hoá

Đông lý

- Tổ VẤN, "Linh lan bí điển luận": "**Tỳ Vị giả, thương lẫm chi quan, ngũ vị xuất yên**": Tỳ Vị là quan coi kho lương, ngũ vị từ đó mà ra.
- Tổ VẤN, "Kinh mạch biệt luận" mô tả đường đi của thức ăn uống: vào Vị, tinh khí được đưa lên Tỳ, Tỳ tán tinh lên Phế, rồi phân bố khắp thân. (Cần đối chiếu nguyên văn.)
- Lý Đông Viên (Tỳ Vị luận, đời Kim Nguyên): "**Nội thương Tỳ Vị, bách bệnh do sinh**": Tỳ Vị tổn thương bên trong thì trăm bệnh sinh ra.
- Quan niệm "**hữu Vị khí tắc sinh, vô Vị khí tắc tử**": còn Vị khí thì còn sống. (Cần lương y xác định xuất xứ.)

Chuỗi Đông lý: thức ăn → Tỳ Vị vận hoá → **thủy cốc tinh vi** → sinh **khí, huyết**, bổ sung **tinh hậu thiên** → nuôi Thân, Khí → (qua tạng Tâm) nuôi Thần. Tỳ chủ **thăng thanh**, Vị chủ

giáng trực: thăng giáng thuận thì tiêu hoá tốt, đầu óc nhẹ.

Tỳ **ưa táo, ghét thấp**. Ăn nhiều đồ sống lạnh, ngọt béo, ăn quá no làm Tỳ bị **thấp khốn**: nặng nề, đầy bụng, mệt mỏi, đầu nặng.

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Tiêu hoá, hấp thu cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho mọi mô	Tỳ Vị là nguồn sinh hoá khí huyết	C1
Thiếu sắt, B12, folate gây thiếu máu, mệt mỏi	Huyết hư do Tỳ Vị kém sinh hoá	C1 (về hiện tượng)
Vì sinh vật đường ruột tác động miễn dịch, chuyển hoá; ruột và não liên lạc hai chiều (trục ruột – não)	Tỳ Vị liên quan khí, thần	C2
Bữa ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế gây dao động đường huyết, có thể kèm uế oải sau ăn	"Thấp khốn Tỳ": nặng nề sau ăn	C2

Hệ quả cho app

Mọi lời khuyên của trụ Ăn uống đều trả lời một câu: **việc này giúp hay làm khó Tỳ Vị?** Tín hiệu Tỳ Vị mà người dùng tự cảm nhận được: **ăn ngon miệng, tiêu hoá nhẹ, đại tiện đều, không đầy bụng, không buồn ngủ rũ sau ăn**. Đây là nền của check-in Ăn uống (phần "Đo lường" bên dưới).

A. Ăn gì

Cơ chế 1. Ngũ cốc vi dưỡng: cấu trúc bữa ăn

Đông lý. *Tổ Vấn, "Tạng khí pháp thời luận": "Ngũ cốc vi dưỡng, ngũ quả vi trợ, ngũ súc vi ích, ngũ thái vi sung. Khí vị hợp nhi phục chí, dĩ bổ tinh ích khí."*: ngũ cốc để nuôi, quả để giúp, thịt để thêm, rau để đủ. Khí vị hoà hợp mà dùng thì bổ tinh ích khí.

Câu này cho một **thứ bậc**: hạt là gốc, rau quả bổ sung, thịt chỉ "ích" chứ không phải chính. Đây là khung rất gần với bữa cơm Việt truyền thống: cơm, canh rau, một món mặn vừa phải.

Tây chứng.

Khuyến nghị hiện đại	Khớp với kinh điển	Cấp
Rau và quả ít nhất 400 g/ngày (WHO)	Ngũ quả vi trợ, ngũ thái vi sung	C1
Chất xơ ít nhất 25 g/ngày ở người lớn (WHO 2023); ngũ cốc nguyên hạt giảm nguy cơ tim mạch, đái tháo đường type 2, ung thư đại trực tràng	Ngũ cốc vi dưỡng	C1

Khuyến nghị hiện đại	Khớp với kinh điển	Cấp
Chất xơ nuôi vi khuẩn ruột, tạo axit béo chuỗi ngắn có lợi cho niêm mạc ruột và chuyển hoá	Tỳ Vị vận hoá tốt	C2
Thịt đỏ nhiều và thịt chế biến sẵn tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng (IARC xếp thịt chế biến nhóm 1)	Ngũ súc chỉ "vi ích", không làm gốc	C1
Đạm đủ cần cho cơ; người lớn khoảng 0,8 g/kg/ngày, người cao tuổi cần nhiều hơn (khoảng 1,0–1,2 g/kg, theo khuyến nghị PROT-AGE)	Dưỡng hình, chống suy Thân ở tuổi già	C1
Thực phẩm siêu chế biến làm ăn vượt nhu cầu: thử nghiệm của Hall và cộng sự (2019) cho thấy người ăn thêm khoảng 500 kcal/ngày khi ăn tự do	Trái "khí vị hợp nhi phục chi"	C1 (thử nghiệm nhỏ, cần bổ sung)

Chỗ cần cẩn thận: "ngũ cốc vi dưỡng" không có nghĩa là ăn nhiều cơm trắng. Người Việt ăn nhiều gạo trắng; tinh bột tinh chế nhiều liên quan nguy cơ đái tháo đường type 2 [C2]. Lục Dưỡng hiểu "ngũ cốc" là **đa dạng hạt, ưu tiên nguyên hạt hoặc ít xay xát** (gạo lứt một phần, khoai, ngô, đậu) 🌾. Không biến thành chế độ "chỉ gạo lứt" (xem cò đỏ).

Tăng được nuôi: Thân ●●●, Khí ●.

Trong app:

- Mô hình **"đĩa cơm Việt"** 🍽️: nửa đĩa rau, một phần tư cơm hoặc tinh bột (ưu tiên ít xay xát), một phần tư đạm (cá, đậu, trứng, thịt), kèm canh. Cần bác sĩ dinh dưỡng chốt tỷ lệ, có thể tham khảo Tháp dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng.
- Check-in nhanh: **"Hôm nay bạn ăn rau mấy bữa?"** (0, 1, 2, 3+). Để trả lời hơn đếm gam.
- Lời khuyên tiệm tiến: thêm một nắm rau vào bữa trưa; đổi một phần cơm trắng thành gạo lứt hoặc khoai.

Cơ chế 2. Ngũ vị điều hoà: mặn, ngọt, béo

Đông lý.

- Tố Vấn, *"Tuyên minh ngũ khí"*: **"Toan nhập Can, khổ nhập Tâm, cam nhập Tỳ, tân nhập Phế, hàn nhập Thận"**: chua vào Can, đắng vào Tâm, ngọt vào Tỳ, cay vào Phế, mặn vào Thận.
- Tố Vấn, *"Sinh khí thông thiên luận"*: **"Âm chi sở sinh, bản tại ngũ vị; âm chi ngũ cung, thương tại ngũ vị"**: âm sinh ra từ ngũ vị, mà năm tạng cũng bị hại bởi ngũ vị. Đủ vị thì nuôi, lệch vị thì hại.
- Tố Vấn, *"Ngũ tạng sinh thành"* mô tả hậu quả ăn thiên một vị, ví dụ **ăn mặn nhiều thì "mạch ngưng sáp"** (mạch đi rít, ú). (*Cần đối chiếu nguyên văn.*)
- Tố Vấn, *"Kỳ bệnh luận"*: ăn nhiều đồ ngọt béo sinh chứng **"tiêu khát"** (gần với đái tháo đường). (*Cần đối chiếu.*)

Chuỗi Đông lý: mỗi vị vào một tạng → vừa đủ thì bổ tạng ấy → thiên một vị thì tạng ấy quá vượng, khắc sang tạng khác → mất quân bình.

Tây chứng. Phần đáng chú ý nhất là hai câu kinh điển trên **khớp với hai nguy cơ dinh dưỡng lớn nhất của người Việt hiện nay:**

Kinh điển	Hiện đại	Cấp
Ăn mặn → mạch ngưng sáp	Muối nhiều làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. WHO khuyên dưới 5 g muối/ngày ; người Việt ăn khoảng gần gấp đôi (điều tra STEPS của Bộ Y tế, cần lấy số mới nhất). Nước mắm, bột canh, mì gói là nguồn muối chính	C1
Ngọt béo → tiêu khát	Đường tự do nhiều, nước ngọt có đường làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2, sâu răng. WHO khuyên đường tự do dưới 10% năng lượng , tốt hơn dưới 5%	C1
Ngũ vị quy kinh từng tạng	Chưa có tương ứng sinh học trực tiếp	C3
Đủ vị, đa dạng	Chế độ ăn đa dạng liên quan đủ vi chất và hệ vi sinh đa dạng	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●● (huyết áp, chuyển hoá), Khí ● (tránh dao động đường huyết).

Trong app:

- Hai lời khuyên ưu tiên cho người Việt: **giảm mặn** và **giảm nước ngọt**. Đây là hai lời khuyên C1 có tác động lớn nhất.
- Mẹo cụ thể theo văn hoá Việt 🇻🇳: chấm nước mắm pha loãng thay vì rót thẳng; không chan nước mắm vào cơm; ăn ít nước dùng mì, phở; giảm bột canh, hạt nêm; thay nước ngọt bằng trà, nước lọc.
- Giải thích Ngũ vị như **hình ảnh văn hoá** [C3]: "người xưa nói vị mặn vào Thận, ăn mặn quá thì mạch rít; ngày nay khoa học xác nhận ăn mặn làm tăng huyết áp [C1]". Khuôn mẫu "người xưa dạy... khoa học cũng thấy..." chỉ dùng khi phía Tây chứng thật sự có bằng chứng.

Cơ chế 3. Tứ khí và thể chất: hàn nhiệt

Đông lý. Mỗi thực phẩm có **tính** (hàn, lương, bình, ôn, nhiệt) và **vị**. Nguyên tắc trị pháp: **"hàn giả nhiệt chi, nhiệt giả hàn chi"** (*Tổ Vĩn, "Chí chân yếu đại luận"*): lạnh thì dùng nóng, nóng thì dùng lạnh. Áp dụng cho dưỡng sinh: người thiên hàn ăn đồ ấm, người thiên nhiệt ăn đồ mát; mùa hè thêm đồ mát, mùa đông thêm đồ ấm.

Ví dụ thường dùng ở Việt Nam [C3]:

Tính	Ví dụ
Hàn, lương	Rau má, mướp đắng, bí đao, đậu xanh, cua, ốc, dưa hấu
Bình	Gạo, khoai lang, đậu đen, cá chép

Tính	Ví dụ
Ôn, nhiệt	Gừng, sả, hành, tiêu, quế, thịt dê, nhãn, vải

Bữa cơm Việt đã có sẵn **phép phối hàn nhiệt**: ăn ốc, cua có gừng, tía tô; ăn cá có gừng, thì là; ăn trứng vịt lộn có rau răm, gừng. Đây là di sản "Nam dược trị Nam nhân" nên đưa vào app 📱.

Tây chứng. Hệ hàn nhiệt **chưa có tương ứng sinh học được kiểm chứng** [C3]. Một số thành phần có tác dụng sinh học riêng (ví dụ gừng giảm buồn nôn [C1–C2]), nhưng điều này không chứng minh hệ hàn nhiệt.

Vì sao vẫn giữ: đây là ngôn ngữ người Việt dùng hằng ngày ("ăn nhiều nhãn nóng người"). Bỏ đi thì mất gần gũi. Giữ lại thì **luôn gắn nhãn C3** và **không bao giờ dùng để thay lời khuyên C1**.

Trong app:

- **Bước lọc thể chất bắt buộc** (lý luận mục V): món ôn nhiệt không gợi ý mạnh cho xu hướng Âm hư, Thấp nhiệt; món hàn lương không gợi ý mạnh cho xu hướng Dương hư, Khí hư.
- Gợi ý **theo mùa và miền** 📍: hè miền Bắc và mùa khô miền Nam thêm canh bí, canh rau má; đông miền Bắc, vùng cao thêm gừng, sả.
- **Không bán, không gợi ý được liệu** trong phiên bản đầu. Chỉ dùng ở thực phẩm thông thường.

B. Ăn thế nào

Cơ chế 4. **Ẩm thực hữu tiết: lượng, tốc độ, chú tâm**

Đông lý.

- *Thượng cổ thiên chân luận*: "**Ẩm thực hữu tiết**": ăn uống có chừng mực.
- *Tổ Vấn, "Tý luận"*: "**Ẩm thực tự bội, trường vị nãi thương**": ăn gấp bội thì tràng vị tổn thương.
- Kinh nghiệm dân gian và sách dưỡng sinh: **ăn bảy, tám phần no**; ăn chậm nhai kỹ.
- *Luận Ngữ*: "**Thực bất ngữ**": khi ăn không nói nhiều. Lục D dưỡng hiểu là **ăn có chú tâm** 📱, không phải cấm trò chuyện trong bữa cơm gia đình.

Chuỗi Đông lý: ăn vừa đủ, ăn chậm → Tỳ Vị không bị quá tải → vận hoá trọn vẹn → không sinh thấp, đàm → thân nhẹ, khí thông.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Ăn quá nhu cầu năng lượng kéo dài dẫn đến tăng cân, béo phì, rối loạn chuyển hoá	C1

Hiện tượng	Cấp
Tín hiệu no (hormone ruột như GLP-1, PYY) cần thời gian; ăn nhanh liên quan ăn nhiều hơn và nguy cơ béo phì	C2
Ăn trong lúc xem màn hình, mất chú ý làm ăn nhiều hơn ở bữa đó và bữa sau	C2
Can thiệp ăn chánh niệm giảm ăn theo cảm xúc và ăn vô độ	C2
Hạn chế năng lượng vừa phải (thử nghiệm CALERIE) cải thiện một số chỉ dấu chuyển hoá ở người khoẻ	C2

Nối với trụ khác:

- **Thiền:** ăn chánh niệm là thiền trong bữa ăn.
- **Cảm xúc:** ăn để xoa dịu cảm xúc (ăn theo cảm xúc) là đường nối giữa Hỏa và Thổ. Khi người dùng nhiều lần ghi "ăn vì buồn, căng thẳng", app gợi ý sang trụ Cảm xúc thay vì chỉ khuyên ăn ít lại.

Tăng được nuôi: Thân ●●, Khí ●●, Tâm ● (qua ăn chú tâm).

Trong app:

- Check-in: **"Sau bữa chính hôm nay, bạn thấy: nhẹ, vừa, hơi no căng, rất no?"**
- Thực hành ngắn 🕒: **"Ba miếng đầu chánh niệm"**: ba miếng đầu tiên nhai chậm, cảm nhận vị, không xem điện thoại.
- **Tuyệt đối không đếm calo** ở phiên bản đầu và không đặt mục tiêu cân nặng. Cách này giảm rủi ro rối loạn ăn uống và hợp tinh thần "trung độ" (xem cờ đỏ).

Cơ chế 5. Thuận thời: giờ ăn và bữa tối

Đông lý.

- Thiên nhân hợp nhất: ban ngày dương khí vượng thì vận hoá mạnh; ban đêm dương khí thu tàng thì vận hoá chậm.
- Giờ Thìn (7-9h) là giờ kinh Vị vượng, giờ Tỵ (9-11h) là giờ kinh Tỳ vượng theo *Tý Ngọ lưu chú* [C3]. Vì vậy dân gian coi trọng bữa sáng.
- *Tổ Vấn, "Nghịch điều luận"*: **"Vị bất hoà tắc ngộ bất an"**: dạ dày không yên thì ngủ không yên. Ăn khuya, ăn no sát giờ ngủ là trái thời.
- Dân gian: **"Sáng ăn như vua, trưa ăn như quan, tối ăn như dân"** (có nhiều dị bản).

Tây chứng (dinh dưỡng theo thời gian, chrononutrition).

Hiện tượng	Cấp
Cơ thể có đồng hồ sinh học ở cả gan, ruột, tụy; dung nạp glucose kém hơn vào buổi tối so với buổi sáng	C1 (về sinh lý)
Ăn no sát giờ ngủ tăng trào ngược dạ dày – thực quản; khuyến nghị lâm sàng là ăn xong trước giờ nằm khoảng 2-3 giờ	C1

Hiện tượng	Cấp
Dồn năng lượng vào buổi sáng, ăn tối sớm cải thiện một số chỉ số chuyển hoá trong thử nghiệm nhỏ	C2
Ăn trong khung giờ giới hạn (ví dụ 8-10 tiếng/ngày): giảm cân chủ yếu do ăn ít đi ; thử nghiệm có đối chứng (Liu và cộng sự, NEJM 2022) không thấy hơn hạn chế calo đơn thuần	C2
Ăn uống giờ giấc đều đặn liên quan chuyển hoá tốt hơn; làm ca đêm và ăn đêm liên quan rối loạn chuyển hoá	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●, Thần ● (qua giấc ngủ).

Trong app:

- Chỉ báo dễ đo: **giờ ăn xong bữa cuối** so với giờ đi ngủ (lấy từ trụ Ngủ nghỉ).
- Lời khuyên C1: ăn xong bữa tối trước giờ ngủ ít nhất 2-3 tiếng; bữa tối nhẹ hơn bữa trưa.
- Không quảng bá nhịn ăn gián đoạn** như phương pháp dưỡng sinh. Nếu người dùng tự chọn, phải qua khoá an toàn (thai kỳ, đái tháo đường dùng thuốc, tiền sử rối loạn ăn uống, dưới 18 tuổi).
- Người làm ca đêm: cần **lộ trình riêng** 📌 (thuộc tam nhân chế nghi, theo đất - hoàn cảnh sống), không áp giờ ăn chuẩn.

C. Đưa gì khác vào

Cơ chế 6. Uống: nước, trà, cà phê

Đông lý. Tân dịch do Tỳ Vị sinh ra từ thủy cốc. Uống vừa đủ, uống ấm thì Tỳ dễ vận hoá; **uống nhiều đồ lạnh, đá** thì tổn Tỳ dương, sinh thấp [C3]. Trà là thức uống truyền thống của người Việt, tính lương, thanh nhiệt [C3].

Tây chứng.

Chất	Hiện đại	Cấp
Nước	Nhu cầu thay đổi theo khí hậu, vận động; ở xứ nóng ẩm cần chú ý hơn. Mất nước nhẹ giảm tập trung, tăng mệt	C1 (mất nước) / C2 (tác động nhẹ lên nhận thức)
Nước ngọt có đường, trà sữa	Nguồn đường tự do lớn; liên quan béo phì, đái tháo đường	C1
Cà phê	Ở người lớn khỏe, khoảng tối đa 400 mg caffeine/ngày được coi là an toàn (EFSA); thai kỳ tối đa khoảng 200 mg. Caffeine có thời gian bán thải trung bình khoảng 5 giờ (dao động lớn giữa các người). Uống caffeine 6 giờ trước khi ngủ vẫn làm giảm giấc ngủ (Drake và cộng sự, 2013)	C1

Chất	Hiện đại	Cấp
Trà	Uống trà liên quan một số lợi ích tim mạch trong nghiên cứu quan sát; cũng chứa caffeine	C2

Lưu ý văn hoá: cà phê sữa đá Việt Nam đậm caffeine và nhiều đường (sữa đặc). Một ly có thể chiếm phần lớn giới hạn caffeine và đường trong ngày. Cần ước lượng theo cách pha phổ biến (giao bác sĩ dinh dưỡng).

Tăng được nuôi: Khí ● (tỉnh táo, tránh mất nước), Thần ● (qua giấc ngủ, khi dùng đúng giờ).

Trong app:

- Check-in: số ly cà phê, trà, nước ngọt; **giờ của ly cà phê cuối**.
- Nối trụ Ngủ nghỉ: nếu điểm ngủ thấp và ly cà phê cuối muộn hơn khoảng 6 tiếng trước giờ ngủ, gợi ý **đời ly cuối lên sớm** trước khi gợi ý điều gì khác. Đây là ví dụ của nguyên tắc "gốc của vấn đề có thể nằm ở trụ khác" (lý luận mục IV.3).
- Không nói "cà phê có hại". Nói về **liều và giờ**.

Cơ chế 7. Tửu và yên: rượu, thuốc lá

Đông lý.

- *Thượng cổ thiên chân luận* chê người đời sau **"dĩ tửu vi tương, dĩ vọng vi thường, tuý dĩ nhập phòng"**: lấy rượu làm nước uống, lấy càn bậy làm thường, say rồi vào phòng, nên sống chưa đến nửa đời đã suy.
- Rượu tính nhiệt, có độc, sinh **thấp nhiệt**, tổn **Can, Tỳ** [C3 về cơ chế].
- Thuốc lá (yên): nhiệt độc, tổn **Phế** 🦋.
- Cả hai thuộc **bất nội ngoại nhân** (lý luận mục VI).

Tây chứng.

Chất	Hiện đại	Cấp
Rượu bia	WHO (2023): không có mức uống an toàn cho sức khỏe. Rượu là chất gây ung thư nhóm 1; gây bệnh gan, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim. Rượu giúp dễ vào giấc nhưng làm vỡ giấc ngủ nửa đêm sau và giảm giấc REM	C1
Thuốc lá	Nguyên nhân hàng đầu của bệnh phổi, tim mạch, ung thư có thể phòng được. Bỏ thuốc ở bất kỳ tuổi nào đều có lợi	C1
Việt Nam	Tỷ lệ uống rượu bia ở nam giới và tỷ lệ hút thuốc ở nam giới đều cao (lấy số mới nhất từ STEPS, GATS)	C1

Tăng được nuôi (khi giảm hoặc bỏ): Thân ●●●, Khí ●●, Thần ● (giấc ngủ).

Trong app:

- Thông điệp trung thực: **"Ít hơn thì tốt hơn"** với rượu. **Không bao giờ** nói "uống rượu vừa phải tốt cho tim" hay quảng bá rượu thuốc, rượu ngâm như dưỡng sinh.

- Văn hoá nhậu, cỗ bàn, tiếp khách: gợi ý thực tế 🍷 (xen nước lọc, ăn trước khi uống, đặt giới hạn trước, có ngày không uống trong tuần). Đây là điểm giao với trụ **Môi trường xã hội**.
- Thuốc lá: không tự xây chương trình cai thuốc ở phiên bản đầu; **chuyển tiếp** đến dịch vụ tư vấn cai thuốc đã được xác minh tại Việt Nam.
- Cờ đỏ: dấu hiệu lệ thuộc rượu (uống buổi sáng, không dừng được, run khi ngưng) → khuyên đi khám. **Cai rượu đột ngột ở người lệ thuộc nặng có thể nguy hiểm**, cần bác sĩ.

Tổng hợp: trụ Ăn uống nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
0. Tỳ Vị vận hoá (nền)	●●●	●●		●	(khung giải thích)
1. Ngũ cốc vi dưỡng	●●●	●			Rau quả ≥ 400 g; chất xơ ≥ 25 g; bột thịt chế biến
2. Ngũ vị điều hoà	●●●	●			Giảm mặn, giảm đường
3. Tứ khí, thể chất	●	●			(C3, chỉ dùng để tuỳ chỉnh)
4. Ấm thực hữu tiết	●●	●●	●		Không ăn quá nhu cầu
5. Thuận thời	●●			●	Ăn xong 2-3 giờ trước khi ngủ
6. Uống		●		●	Caffeine theo liều và giờ
7. Từu, yên	●●●	●●		●	Ít rượu hơn, không thuốc lá

Bảng này khớp với bảng của lý luận v0.3 (Ăn uống: Thân ●●●, Khí ●). Riêng **Thần ●** (qua giấc ngủ, ở cơ chế 5, 6, 7) là đề xuất bổ sung, cần hội đồng xem xét.

Ăn uống tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Ăn uống → Ngủ nghỉ	Vị bất hoà tắc ngọạ bất an; ăn khuya, cà phê muộn, rượu làm giấc ngủ kém	C1
Ngủ nghỉ → Ăn uống	Thiếu ngủ làm tăng cảm giác đói, thèm đồ ngọt béo	C1-C2
Cảm xúc → Ăn uống	Hỏa sinh Thổ: tâm an thì ăn ngon; căng thẳng gây ăn theo cảm xúc hoặc chán ăn; tư thương Tỳ	C2
Ăn uống → Cảm xúc	Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải liên quan nguy cơ trầm cảm thấp hơn; thử nghiệm SMILES (2017) nhỏ nhưng tích cực	C2
Ăn uống → Luyện tập	Đủ năng lượng, đủ đạm thì tập có sức, cơ hồi phục; Tỳ chủ cơ nhục	C1
Thiền → Ăn uống	Ăn chánh niệm	C2
Môi trường → Ăn uống	Bữa cơm gia đình; văn hoá nhậu; môi trường thực phẩm (nhiều quán ăn nhanh, đồ ngọt)	C2

Đo lường trụ Ăn uống 🍴

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Check-in hằng ngày (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Hôm nay bạn ăn rau mấy bữa?	0 · 1 · 2 · 3+	1
2	Hôm nay bạn có uống nước ngọt, trà sữa không?	Không · 1 ly · 2+ ly	2, 6
3	Sau bữa chính, bạn thấy thế nào?	Nhẹ · Vừa · Hơi no căng · Rất no	4
4	Bạn ăn xong bữa cuối lúc mấy giờ?	Giờ	5
5	Ly cà phê hoặc trà cuối lúc mấy giờ?	Giờ / Không uống	6
6	Hôm nay bạn có uống rượu bia không?	Không · 1-2 ly · 3+ ly	7

Câu 4-6 có thể bật tắt; người dùng chọn theo trọng tâm tuần (tiệm tiến).

Hàng tuần

- **Tín hiệu Tỳ Vị tự cảm nhận** (0-10): ăn ngon miệng, tiêu hoá nhẹ, đại tiện đều, không đầy bụng.
- **Ăn mặn**: số bữa có chấm, chan nước mắm nhiều; số lần ăn mì gói, đồ chế biến sẵn.

Định kỳ (đề xuất, cần chuyên gia chọn công cụ đã thẩm định tiếng Việt)

- Bảng tần suất thực phẩm rút gọn.
- **AUDIT-C** (3 câu sàng lọc rượu) nếu người dùng có uống rượu.
- Sàng lọc rối loạn ăn uống ngắn (ví dụ SCOFF) trước khi bật bất kỳ tính năng nào liên quan cân nặng.

Không đo

- **Không đếm calo, không chấm điểm món ăn "tốt/xấu"**, không đặt mục tiêu cân nặng ở phiên bản đầu.
- Không chụp ảnh món ăn để AI chấm điểm (độ chính xác thấp, dễ gây lo âu).

An toàn riêng cho trụ Ăn uống

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng duyệt.**

Cờ đỏ cần đi khám

Dấu hiệu	Hành động
Sụt cân không chủ ý (ví dụ trên 5% trong 6 tháng)	Khuyến đi khám
Khó nuốt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc có máu, đau bụng kéo dài	Khuyến đi khám ngay
Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài, nhất là sau 45-50 tuổi	Khuyến đi khám (tầm soát đại trực tràng)
Dấu hiệu rối loạn ăn uống: sợ tăng cân, nhịn ăn kéo dài, ăn vô độ rồi nôn, sàng lọc dương tính	Dừng mọi lời khuyên về lượng ăn; khuyến gặp chuyên gia
Dấu hiệu lệ thuộc rượu	Khuyến đi khám; cảnh báo không tự cai đột ngột nếu uống nặng

Chế độ ăn cực đoan

Lục Dưỡng **không khuyến nghị** và sẽ **cảnh báo** khi người dùng theo:

- Chế độ chỉ ăn một loại (ví dụ chỉ gạo lứt muối mè kéo dài). Đã có những ca suy dinh dưỡng, tổn thương nặng khi áp dụng cực đoan.
- Nhịn ăn nhiều ngày, "thải độc" bằng nước ép hay thực phẩm chức năng.
- **Bỏ thuốc điều trị** để chữa bệnh bằng ăn uống.

Câu chuẩn trong app: *"Ăn uống là nền của sức khỏe, nhưng không thay thế điều trị. Hãy giữ thuốc bác sĩ kê và trao đổi với bác sĩ trước khi thay đổi lớn chế độ ăn."*

Khoá theo tình trạng (bổ sung)

Tình trạng	Khoá
Đái tháo đường đang dùng thuốc hạ đường huyết, insulin	Khoá gợi ý bỏ bữa, ăn khung giờ giới hạn (nguy cơ hạ đường huyết)
Bệnh thận mạn	Khoá gợi ý tăng đạm, tăng rau quả nhiều kali; kèm "hỏi bác sĩ"
Dùng thuốc chống đông warfarin	Nhắc giữ lượng rau lá xanh ổn định (vitamin K); hỏi bác sĩ
Bệnh gout	Lời khuyên đạm, rượu bia kèm "hỏi bác sĩ"
Dị ứng, không dung nạp thức ăn	Lọc mọi gợi ý món ăn
Thai kỳ, cho con bú	Giới hạn caffeine thấp hơn; khoá dược liệu, nhịn ăn; nhắc tránh rượu hoàn toàn

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🍴

Mỗi tuần chọn **1-2 việc**, theo tăng đang yếu và lời khuyên C1 trước:

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Thuận thời	Ăn xong bữa tối trước giờ ngủ 3 tiếng
2	Ngũ vị	Pha loãng nước mắm chấm; không chan nước mắm vào cơm
3	Ngũ cốc vi dưỡng	Thêm rau vào bữa sáng hoặc bữa trưa
4	Uống	Đổi một ly nước ngọt hoặc trà sữa thành trà, nước lọc; dời ly cà phê cuối trước 14h
5	Hữu tiết	"Ba miếng đầu chánh niệm"; dừng ở bảy, tám phần no
6	Tứ khí	Thêm một món theo mùa, có lọc thể chất

Người uống rượu, hút thuốc: ưu tiên cơ chế 7 sớm, vì tác động lớn nhất.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

- Đối chiếu nguyên văn: *Linh lan bí điển luận, Kinh mạch biệt luận, Tạng khí pháp thời luận, Tuyên minh ngũ khí, Sinh khí thông thiên luận, Ngũ tạng sinh thành, Kỳ bệnh luận, Chí chân yếu đại luận, Tý luận, Nghịch điều luận, Thượng cổ thiên chân luận*; xuất xứ câu "hữu Vị khí tắc sinh".
- Bảng tính vị (hàn nhiệt) của thực phẩm Việt thông dụng; phép phối hàn nhiệt trong bữa cơm Việt.
- Nguyên văn về ăn uống trong "Vệ sinh yếu quyết" (Hải Thượng Lãn Ông) và trước tác của Tuệ Tĩnh.
- Gợi ý theo mùa cho miền Bắc, miền Nam, vùng cao.

Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng:

- Tỷ lệ "đĩa cơm Việt"; đối chiếu Tháp dinh dưỡng và Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý của Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
- Số liệu mới nhất về muối, đường, rượu bia, thuốc lá ở người Việt.
- Lượng caffeine, đường trong các thức uống phổ biến (cà phê sữa đá, trà sữa).
- Bộ câu hỏi check-in và công cụ sàng lọc (AUDIT-C, SCOFF) có bản tiếng Việt đã thẩm định.
- Danh sách cờ đỏ và khoá theo bệnh.
- Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định trong tài liệu này.

Chuyên gia tâm lý:

- Rủi ro rối loạn ăn uống khi theo dõi ăn uống; cách nói không gây mặc cảm.

Trụ Luyện tập

Hành chủ đạo: Mộc

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Đông lý**, **Tây chứng**, **tăng được nuôi**, **trong app**.

Trụ Luyện tập có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Động	Có vận động không	1. Hộ xu bất đổ: vận động hằng ngày, phá ngồi lâu
B. Bốn phẩm chất của thân	Rèn cái gì	2. Khí lực: sức bền tim phổi · 3. Cân cốt nhục: sức cơ, xương · 4. Nhu và hoà: mềm dẻo, thăng bằng, đạo dẫn
C. Cách tập	Tập thế nào	5. Trung độ: liều lượng và hồi phục · 6. Thuận thời: theo mùa, giờ, khí hậu, không khí

Nền chung là **cơ chế gốc: động thì khí huyết lưu thông**.

Hành chủ đạo: Mộc (Can chủ cân, chủ sơ tiết; Mộc tính sinh phát). **Tạng cùng tham gia:** Tỳ (chủ cơ nhục, tứ chi), Thận (chủ cốt), Phế (chủ khí, hô hấp), tạng Tâm (chủ huyết mạch). Việc gán hành là ☯.

Cơ chế gốc: động thì khí huyết lưu thông

Đông lý

- Lã Thị Xuân Thu: "**Lưu thủy bất hủ, hộ xu bất đổ**": nước chảy thì không thối, trục cửa xoay thì không một. Thân người cũng vậy: động thì không trệ.
- Lời Hoa Đà dạy học trò (*Tam quốc chí*, "*Hoa Đà truyện*"): "**Nhân thể dục đắc lao động, dẫn bất đương sử cực nhĩ. Động điều tắc cốc khí đắc tiêu, huyết mạch lưu thông, bệnh bất đắc sinh**": thân người cần được vận động, nhưng không nên đến mức kiệt. Động thì cơm nước tiêu hoá, huyết mạch lưu thông, bệnh không sinh được. (*Cần đối chiếu nguyên văn*.) Hoa Đà sáng tạo **Ngũ cầm hí** (bài tập mô phỏng hổ, hươu, gấu, vượn, chim).
- Tổ Vãn, "*Dị pháp phương nghi luận*" nêu "**đạo dẫn án kiều**" (dẫn khí, xoa bóp, vận động) là phép chữa sinh ra ở vùng trung ương. (*Cần đối chiếu*.)
- Tuệ Tĩnh: "**luyện hình**" là một trong bảy phép dưỡng sinh.

Chuỗi Đông lý: vận động → dương khí được phát động → khí hành thì huyết hành → kinh lạc thông, Tỳ vận hoá tốt ("cốc khí đặc tiêu"), Can sơ tiết được → thân vững, khí thông, tâm thư thái.

Câu của Hoa Đà chứa sẵn **hai vế của trụ Luyện tập:** *cần vận động* (vế "dục đặc lao động") và *không được quá* (vế "bất đương sử cực"). Vế thứ hai là cơ chế 5.

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Vận động thể lực đều đặn giảm tử vong do mọi nguyên nhân, bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2, một số ung thư, sa sút trí tuệ	Bệnh bất đắc sinh	C1
Vận động tăng tuổi máu, cải thiện chức năng mạch máu, độ nhạy insulin	Huyết mạch lưu thông	C1
Vận động nhẹ sau ăn giảm đường huyết sau ăn	Cốc khí đặc tiêu	C1-C2
Vận động kích thích nhu động ruột, giảm táo bón	Tỳ vận hoá	C2
Lười vận động là một trong các yếu tố nguy cơ tử vong hàng đầu toàn cầu (WHO)	Trệ thì sinh bệnh	C1

Hệ quả cho app 📱

Mọi lời khuyên trả lời hai câu: **có làm khí huyết lưu thông hơn không?** và **có vượt quá sức không?** Tín hiệu tự cảm nhận: **thân nhẹ, khớp linh hoạt, ngủ ngon sau ngày vận động, không đau kéo dài sau tập.**

A. Động

Cơ chế 1. Hộ xu bất đố: vận động hằng ngày, phá ngội lâu

Đông lý.

- Tố Vấn, "Tuyên minh ngũ khí": "**Cửu toạ thương nhục, cửu ngọa thương khí**": ngội lâu hại cơ nhục, nằm lâu hại khí.
- Tứ khí điều thần đại luận dạy mùa xuân "**dạ ngọa tảo khởi, quảng bộ ư đình**": ngủ muộn dậy sớm, đi dạo thông thả ngoài sân. Đi bộ là phép dưỡng sinh cơ bản nhất.
- Dân gian: "**Bách bộ tẩu**" (ăn xong đi trăm bước) 📍 (xuất xứ cần lương y xác định).

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020): hạn chế thời gian ngội ; thay ngội bằng vận động ở bất kỳ cường độ nào cũng có lợi. " Có còn hơn không ": không có ngưỡng tối thiểu để bắt đầu có lợi	C1

Hiện tượng	Cấp
Ngồi lâu là yếu tố nguy cơ độc lập. Phân tích gộp của Ekelund và cộng sự (Lancet 2016): khoảng 60–75 phút vận động vừa mỗi ngày làm mất đi phần lớn nguy cơ tăng tử vong do ngồi nhiều	C1
Số bước: phân tích gộp của Paluch và cộng sự (Lancet Public Health 2022): lợi ích về tử vong tăng dần và chững lại ở khoảng 6.000-8.000 bước/ngày với người từ 60 tuổi, 8.000-10.000 bước với người dưới 60 tuổi . Con số 10.000 bước không phải ngưỡng bắt buộc	C1
Ngắt quãng thời gian ngồi (đứng dậy, đi lại vài phút mỗi 30–60 phút) cải thiện đường huyết sau ăn	C2
Đi bộ 10–15 phút sau ăn giảm đường huyết sau ăn	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●, Khí ●●.

Trong app:

- Dữ liệu sẵn có: **số bước, thời gian ngồi** (từ điện thoại, đồng hồ, nếu người dùng cho phép).
- Mục tiêu bước **so với chính mình**: tăng dần khoảng 500–1.000 bước/ngày so với mức trung bình tuần trước, không áp ngay 10.000 bước 📌.
- Nhắc "**đứng dậy, trục của xoay**" 📌 sau khoảng 45–60 phút ngồi liền (người dùng chọn tần suất, có thể tắt).
- Nối trụ Ăn uống: gợi ý **đi bộ 10 phút sau bữa trưa hoặc bữa tối** (vẫn cách giờ ngủ đủ xa).

B. Bốn phẩm chất của thân

Ba cơ chế dưới đây tương ứng với ba nhóm vận động trong khuyến nghị hiện đại (sức bền, sức cơ, thăng bằng và mềm dẻo), và với ba tạng chủ hình thể trong cổ truyền:

Phẩm chất	Cổ truyền	Hiện đại
Khí lực	Phế chủ khí, tạng Tâm chủ huyết mạch	Sức bền tim phổi
Cân cốt nhục	Can chủ cân, Thận chủ cốt, Tỳ chủ cơ nhục	Sức cơ, sức xương
Nhu và hoà	Cân mềm, khí hoà, thần định	Mềm dẻo, thăng bằng, phối hợp

Cơ chế 2. Khí lực: sức bền tim phổi

Đông lý. Phế chủ khí, chủ hô hấp; tạng Tâm chủ huyết mạch. Vận động làm hơi thở sâu, mạch mạnh, "tông khí" (khí tích ở ngực, gồm khí trời hít vào và cốc khí) được bồi đắp 📌. Người khí hư thì đi ít đã mệt, hụt hơi.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020) cho người trưởng thành: 150–300 phút/tuần cường độ vừa hoặc 75–150 phút/tuần cường độ cao , hoặc kết hợp tương đương	C1

Hiện tượng	Cấp
Thể lực tim phổi (VO2max) là một trong những yếu tố dự báo tuổi thọ mạnh nhất	C1
Vận động sức bền giảm huyết áp, cải thiện mỡ máu và đường huyết	C1
Vận động giảm triệu chứng trầm cảm, lo âu với hiệu quả đáng kể; phân tích gộp mạng của Noetel và cộng sự (BMJ 2024) cho thấy đi bộ, chạy bộ, yoga, tập sức cơ đều có tác dụng	C1
Vận động giảm mệt mỏi ở nhiều nhóm người, kể cả người bệnh mạn tính	C1- C2

Cách nhận biết cường độ, không cần thiết bị 📌:

Cường độ	Thử nói chuyện	Thang gắng sức 0-10
Nhẹ	Hát được	1-3
Vừa	Nói được câu, không hát được	4-6
Cao	Chỉ nói được vài từ	7-8

Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, cầu lông, nhảy dân vũ đều là cường độ vừa với đa số người.

Tăng được nuôi: Khí ●●●, Thân ●●, Tâm ● (giảm lo âu, trầm cảm).

Trong app:

- Đơn vị chính: **"phút vận động vừa"** trong tuần (không phải calo). Mục tiêu tăng dần đến 150 phút.
- Gợi ý theo văn hoá Việt: đi bộ công viên buổi sáng, cầu lông, đạp xe, bơi, dân vũ.
- Check-in: **"Hôm nay bạn có vận động đến mức hơi thở nhanh hơn không? Bao nhiêu phút?"**

Cơ chế 3. Cân cốt nhục: sức cơ, sức xương

Đông lý.

- **Tỳ chủ cơ nhục, chủ tứ chi.** Tỳ khí đủ thì cơ đầy đặn, tay chân có lực.
- **Can chủ gân.** *Tố Vấn, "Thượng cổ thiên chân luận"* mô tả nam giới đến tuổi bảy tám (56) thì **"Can khí suy, gân bất năng động"**. (*Cần đối chiếu.*)
- **Thận chủ cốt, sinh tủy.** Thận tinh đầy thì xương chắc; Thận suy thì lưng gối mỏi, xương giòn.
- Sự suy của cân, cốt, nhục theo tuổi là hình ảnh cổ truyền rất gần với **teo cơ tuổi già** và **loãng xương** hiện đại.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020): tập sức cơ ít nhất 2 ngày/tuần , tác động các nhóm cơ lớn	C1
Khối cơ và sức cơ giảm dần từ tuổi trung niên (teo cơ tuổi già, sarcopenia); tập kháng lực là biện pháp hiệu quả nhất để làm chậm và đảo ngược	C1

Hiện tượng	Cấp
Sức nắm tay là chỉ dấu dự báo tử vong và khuyết tật	C1
Tập chịu lực và kháng lực giúp duy trì mật độ xương	C1-C2
Tập sức cơ cải thiện độ nhạy insulin, giảm đau lưng mạn tính	C1-C2
Đủ đạm kết hợp tập kháng lực hiệu quả hơn tập đơn thuần	C1

Tăng được nuôi: Thân ●●●, Khí ●.

Trong app:

- Bài tập **không cần dụng cụ**, làm tại nhà 🏠: đứng lên ngồi xuống ghế, chống đẩy vào tường hoặc bàn, kiễng gót, nhón chân lên bậc thang, cầm chai nước làm tạ.
- Nhịp tuần: 2-3 buổi sức cơ, cách ngày.
- Người cao tuổi: ưu tiên tập sức chân (đứng lên ngồi xuống, kiễng gót), vì liên quan trực tiếp đến đi lại độc lập và phòng ngã.
- Nổi trụ Ăn uống: nhắc **đủ đạm** (cơ chế 1 của trụ Ăn uống), nhất là người từ 60 tuổi.
- Tự kiểm tra định kỳ 📅: **số lần đứng lên ngồi xuống ghế trong 30 giây** (theo dõi xu hướng của chính mình; ngưỡng chuẩn do chuyên gia chốt).

Cơ chế 4. Nhu và hoà: mềm dẻo, thăng bằng, đạo dẫn

Đông lý.

- **Đạo dẫn:** "*đạo khí lệnh hoà, dẫn thể lệnh nhu*", tức dẫn khí cho hoà, dẫn thân cho mềm (cách giải thích thường gặp, xuất xứ cần lương y xác định). Đạo dẫn kết hợp **động tác chậm, hơi thở và ý niệm**.
- Các phép đạo dẫn truyền thống: **Ngũ cầm hí** (Hoa Đà), **Bát đoạn cầm**, **Dịch cân kinh**, **Thái cực quyền**.
- **Di sản Việt:** phương pháp **dưỡng sinh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng** (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) kết hợp thở, xoa bóp, vận động khớp, được phổ biến rộng ở Việt Nam. Đây là nguồn quan trọng cho tinh thần "Nam dược trị Nam nhân" mở rộng sang vận động 🏃. (*Cần tư liệu gốc.*)
- Can chủ cân: cân mềm thì khớp linh hoạt; cân cứng, co rút là dấu hiệu Can huyết không nuôi được cân.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
WHO (2020): người từ 65 tuổi nên tập đa thành phần, nhấn mạnh thăng bằng và sức cơ, ít nhất 3 ngày/tuần để phòng ngã	C1
Tập thăng bằng và sức cơ, bao gồm Thái cực quyền , giảm nguy cơ ngã ở người cao tuổi (tổng quan Cochrane, Sherrington và cộng sự 2019)	C1
Thái cực quyền cải thiện thăng bằng, giảm đau trong thoái hoá khớp gối	C1-C2

Hiện tượng	Cấp
Khí công, Bát đoạn cầm cải thiện một số chỉ số thể chất, giấc ngủ, tâm trạng; nhiều nghiên cứu còn nhỏ, chất lượng không đều	C2
Giãn cơ cải thiện tầm vận động khớp; không phòng được chấn thương như từng tin	C1 (tầm vận động) / C2 (chấn thương)
Khái niệm "dẫn khí", "thông kinh lạc" khi tập	C3

Vì sao đạo dẫn hợp với Lục Dưỡng: đạo dẫn là chỗ trụ Luyện tập **gặp trụ Thiên**. Động tác chậm cùng hơi thở và sự chú tâm nuôi cả Khí, Tâm và Thần. Đây là dạng vận động phù hợp với người cao tuổi, người mới bắt đầu và người đang căng thẳng.

Tăng được nuôi: Thân ●●, Khí ●●, Tâm ●, Thần ●.

Trong app:

- Thư viện bài đạo dẫn ngắn có video: Bát đoạn cầm (khoảng 10–15 phút), bài dưỡng sinh buổi sáng, bài giãn cơ cho dân văn phòng. **Phải do người có chuyên môn biên soạn và trình diễn.**
- Khi nói về đạo dẫn: nói **"giúp thăng bằng, dẻo dai, thư thái" [C1-C2]**, không nói "đả thông kinh mạch chữa bệnh".
- Bài tập thăng bằng an toàn tại nhà: đứng một chân có vịn ghế, đi gót nối mũi.

C. Cách tập

Cơ chế 5. Trung độ: liều lượng và hồi phục

Đông lý.

- Hoa Đà: **"dẫn bất dương sử cực nhĩ"**: không nên tập đến kiệt.
- Tuyên minh ngũ khí*: **"Cửu hành thương cân, cửu lập thương cốt"**: đi lâu hại gân, đứng lâu hại xương.
- Thượng cổ thiên chân luận*: **"Bất vọng tác lao"**: không lao lực càn.
- Ra mồ hôi quá nhiều làm hao **tân dịch** và **khí** ("hãn xuất quá đa thương khí, thương âm") [C3]. Đặc biệt mùa đông, kinh dạy **"vô tiết bì phu"**: đừng để da ra mồ hôi nhiều. (Cần đối chiếu.)

Chuỗi Đông lý: vừa sức → khí huyết lưu thông, dương được phát động. Quá sức → hao khí, tổn tân dịch, thương cân cốt → mệt mỏi, đau, dễ bệnh. Đây là biểu hiện của pháp tắc **trung độ** và **thủ chân**.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Tăng khối lượng tập quá nhanh làm tăng nguy cơ chấn thương do quá tải	C1

Hiện tượng	Cấp
Tập quá mức kéo dài không đủ hồi phục gây mệt mỏi kéo dài, giảm hiệu suất, rối loạn giấc ngủ, tâm trạng	C1 (vận động viên) / C2 (người thường)
Đau nhức cơ sau tập 1-2 ngày (đau cơ khởi phát muộn) là bình thường; đau khớp, đau nhói, sưng là dấu hiệu cần dừng	C1
Thiếu ngủ giảm hồi phục và tăng nguy cơ chấn thương	C1-C2
Lợi ích sức khỏe vẫn tiếp tục khi tập nhiều hơn 300 phút/tuần, nhưng tăng ít dần; người thường không cần tập kiệt sức để có lợi	C1

Hai nhóm người cân trung độ theo hai hướng 📌:

- **Người ít vận động:** rủi ro chính là **không làm gì**. Thông điệp: "một chút cũng có lợi".
- **Người tập nhiều, cầu toàn:** rủi ro chính là **làm quá**. Thông điệp: "nghỉ cũng là tập".

Tăng được nuôi: bảo vệ cả bốn tầng; chủ yếu Thân ●● và Khí ●●.

Trong app:

- Quy tắc tăng tiến 📌: mỗi tuần tăng tổng phút vận động **khoảng 10-20%**, không hơn (cân chuyên gia chốt).
- Check-in sau tập: **"Bạn thấy: khoan khoái · mệt dễ chịu · mệt rồi · đau?"**. "Mệt rồi" hai lần liên tiếp hoặc "đau" thì gợi ý giảm hoặc nghỉ.
- **Nhắc ngũ lao:** tuần liên tiếp không có ngày nghỉ, hoặc phút vận động tăng đột ngột, thì nhắc "cửu hành thương cân".
- Nối trụ Ngủ nghỉ: điểm ngủ thấp nhiều đêm thì **giảm cường độ** để xuất, ưu tiên đạo dẫn, đi bộ nhẹ.

Cơ chế 6. Thuận thời: theo mùa, giờ, khí hậu, không khí

Đông lý. Tứ khí điều thần đại luận dạy vận động thuận mùa:

Mùa	Kinh điển	Hàm ý vận động 📌
Xuân (phát trần)	"Dạ ngọa táo khởi, quảng bộ ư đình"	Dậy sớm, đi bộ, giãn cơ; thả lỏng, sinh phát
Hạ (phồn tú)	"Vô yếm ư nhật" (dùng chán ngày dài)	Hoạt động nhiều hơn nhưng tránh nắng gắt; bù nước
Thu (dung bình)	"Tảo ngọa táo khởi, dữ kê câu hưng" (ngủ sớm dậy sớm, cùng dậy với gà)	Thu liễm dần, vừa phải
Đông (bế tàng)	"Tảo ngọa vẫn khởi, tất đãi nhật quang... vô tiết bì phụ" (ngủ sớm dậy muộn, đợi có nắng, dùng để ra mồ hôi nhiều)	Tập khi trời đã ấm, khởi động kỹ, không tập đến đầm đìa mồ hôi

(Cân lương y đối chiếu nguyên văn từng câu.)

Tây chúng.

Hiện tượng	Cấp
Nắng nóng, độ ẩm cao làm tăng nguy cơ kiệt sức do nóng, sốc nhiệt; cần bù nước, tránh giờ nắng gắt, giảm cường độ	C1
Lạnh làm tăng gánh nặng tim mạch, nhất là ở người có bệnh tim, tăng huyết áp; cần khởi động kỹ, giữ ấm	C1
Ô nhiễm không khí (bụi mịn PM2.5) cao: nên giảm vận động gắng sức ngoài trời, nhất là người có bệnh tim phổi	C1-C2
Đón ánh sáng buổi sáng hỗ trợ nhịp sinh học, giấc ngủ	C1
Tập gắng sức nặng sát giờ ngủ (dưới khoảng 1 giờ) có thể làm khó ngủ ở một số người; tập vừa buổi tối nhìn chung không hại giấc ngủ	C2
Giờ kinh vượng để tập (ví dụ giờ Mão, kinh Đại tràng)	C3

Theo đất - Việt Nam 🇻🇳:

- Miền Bắc mùa đông lạnh ẩm: người cao tuổi, người tăng huyết áp tránh ra ngoài tập quá sớm khi trời rét đậm; tập trong nhà, đợi nắng lên.
- Miền Nam nóng quanh năm: ưu tiên sáng sớm, chiều tối; bù nước, tránh 10h-16h.
- Đô thị lớn (Hà Nội, TP.HCM) có những đợt bụi mịn cao: đọc chỉ số chất lượng không khí trước khi tập ngoài trời.

Tăng được nuôi: Thân ●, Khí ●, Thần ● (qua nhịp ngủ).

Trong app:

- Kết nối **thời tiết và chỉ số chất lượng không khí (AQI)** theo vị trí (nếu người dùng cho phép): khi AQI xấu hoặc nắng nóng gay gắt, tự đổi gợi ý sang bài tập trong nhà.
- Gợi ý vận động theo **tiết khí có bộ điều chỉnh cho miền Nam** (như lý luận mục V).
- Nhắc không tập gắng sức trong khoảng 1-2 giờ trước giờ ngủ, nếu người dùng ngủ kém.

Tổng hợp: trụ Luyện tập nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
0. Khí huyết lưu thông (nền)	●●	●●●	●		(khung giải thích)
1. Hộ xu bất đổ	●●	●●			Bớt ngồi; tăng bước so với chính mình
2. Khí lực	●●	●●●	●		150-300 phút/tuần cường độ vừa
3. Cân cốt nhục	●●●	●			Sức cơ ≥ 2 ngày/tuần
4. Nhu và hoà	●●	●●	●	●	Thăng bằng ≥ 3 ngày/tuần ở người từ 65 tuổi
5. Trung độ	●●	●●			Tăng từ từ; nghỉ đủ
6. Thuận thời	●	●		●	Tránh nắng nóng, lạnh, bụi mịn

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Luyện tập: Thân ●●, Khí ●●●, Tâm ●). Đề xuất bổ sung **Thần ●** qua đạo dẫn (cơ chế 4) và qua giấc ngủ, cần hội đồng xem xét.

Luyện tập tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Ngủ nghỉ → Luyện tập	Thủy sinh Mộc: ngủ đủ thì có sức tập; thiếu ngủ giảm hiệu suất, hồi phục	C1
Luyện tập → Ngủ nghỉ	Vận động đều đặn cải thiện chất lượng giấc ngủ	C1-C2
Luyện tập → Cảm xúc	Mộc sinh Hỏa: vận động giảm trầm cảm, lo âu, cải thiện tâm trạng	C1
Ăn uống ↔ Luyện tập	Đủ năng lượng, đủ đạm để tập; đi bộ sau ăn giảm đường huyết	C1
Luyện tập ↔ Thiền	Đạo dẫn, Thái cực, yoga là "thiền động"	C2
Môi trường → Luyện tập	Khí hậu, ô nhiễm, công viên gần nhà, bạn tập; tập theo nhóm giúp duy trì thói quen	C2
Luyện tập → Môi trường xã hội	Tập nhóm (đi bộ, dân vũ, câu lạc bộ dưỡng sinh) tạo kết nối xã hội	C2

Đo lường trụ Luyện tập 📏

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Tự động (nếu người dùng cho phép)

- **Số bước** và **phút vận động** từ điện thoại hoặc đồng hồ.
- **Thời gian ngồi liên** (nếu thiết bị hỗ trợ).
- Không dùng "calo đốt cháy" làm chỉ số chính (sai số lớn, dễ gắn với ăn uống bù trừ).

Check-in hằng ngày (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Hôm nay bạn vận động đến mức thở nhanh hơn bao nhiêu phút?	0 · <10 · 10-30 · >30 (hoặc lấy từ thiết bị)	2
2	Hôm nay bạn có tập sức cơ hoặc đạo dẫn không?	Không · Sức cơ · Đạo dẫn/giãn cơ · Cả hai	3, 4
3	Sau khi tập, bạn thấy thế nào?	Khoan khoái · Mệt dễ chịu · Mệt rã rời · Đau	5
4	Hôm nay bạn có ngồi liên quá 2 tiếng không?	Có · Không	1

Hàng tuần

- Tổng **phút vận động vừa** so với mục tiêu cá nhân.
- Số ngày có tập sức cơ** (mục tiêu ≥ 2) và **số ngày nghỉ** (ít nhất 1).
- Tín hiệu thân tự cảm nhận** (0-10): thân nhẹ, khớp linh hoạt, không đau kéo dài.

Định kỳ (mỗi 4-12 tuần, cần chuyên gia chọn và chuẩn hoá)

- Đứng lên ngồi xuống ghế 30 giây** (sức chân).
- Đứng một chân** (thăng bằng), có vịn an toàn.
- Bảng hỏi vận động ngắn đã thẩm định tiếng Việt (ví dụ GPAQ của WHO).

Không đo

- Không xếp hạng, không so sánh với người khác trong phiên bản đầu (tránh tập quá sức để "thắng").
- Không gán điểm cho thân hình, cân nặng.

An toàn riêng cho trụ Luyện tập

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần bác sĩ duyệt.**

Sàng lọc trước khi bắt đầu

Trước khi gợi ý vận động cường độ vừa trở lên, app hỏi bộ câu sàng lọc sẵn sàng vận động (dựa trên **PAR-Q+**, cần bản tiếng Việt và kiểm tra bản quyền). Có một câu "Có" thì: **chỉ gợi ý vận động nhẹ** (đi bộ chậm, đạp dẫn nhẹ) và **khuyến hỏi bác sĩ** trước khi tăng.

Cờ đỏ khẩn cấp: dừng tập ngay

Dấu hiệu khi đang tập	Hành động
Đau, tức ngực; khó thở bất thường; ngất hoặc sắp ngất; tim đập rất nhanh, loạn nhịp	Dừng ngay. Nếu không đỡ sau vài phút nghỉ, gọi cấp cứu 115
Yếu, tê một bên người, méo miệng, nói khó	Gọi cấp cứu ngay
Lú lẫn, ngừng ra mồ hôi, da nóng khi tập trời nóng	Nghi sốt nhiệt: đưa vào chỗ mát, làm mát, gọi cấp cứu

Cờ đỏ cần đi khám

Dấu hiệu	Hành động
Đau khớp, đau xương kéo dài trên 1-2 tuần, sưng, không chịu lực được	Ngừng bài tập gây đau; khuyến đi khám
Khó thở, mệt khi gắng sức nhẹ mà trước đây không bị	Khuyến đi khám

Dấu hiệu	Hành động
Ngã nhiều lần, chóng mặt khi đứng dậy	Khuyến đi khám; chuyển sang bài thăng bằng có vịn
Tập bù trừ sau ăn, sợ không tập thì tăng cân, tập dù đang chấn thương	Nghỉ vận động cường bức; khuyến gặp chuyên gia; giảm nhắc nhở

Khoá theo tình trạng

Tình trạng	Khoá hoặc điều chỉnh
Bệnh tim mạch đã biết, sau đột quy, sau phẫu thuật	Chỉ gợi ý theo chỉ định bác sĩ hoặc chương trình phục hồi chức năng
Tăng huyết áp chưa kiểm soát (ví dụ từ 180/110 mmHg trở lên)	Khoá vận động gắng sức; khuyến đi khám
Đái tháo đường dùng insulin hoặc sulfonylurea	Nhắc nguy cơ hạ đường huyết; mang theo đồ ngọt; hỏi bác sĩ
Loãng xương	Tránh gập cột sống có tải, vận mình mạnh; ưu tiên thăng bằng, sức cơ có hướng dẫn
Thai kỳ	Vận động vừa nhìn chung có lợi (WHO khuyến khoảng 150 phút/tuần nếu không có chống chỉ định); khoá môn có va chạm, nguy cơ ngã, tập nằm ngửa lâu ở giai đoạn sau; hỏi bác sĩ sản
Người từ 65 tuổi, người có nguy cơ ngã	Ưu tiên bài có vịn, thăng bằng; không gợi ý cường độ cao khi chưa sàng lọc
Đang sốt, ốm cấp	Tạm dừng gợi ý tập; nghỉ ngơi

Lộ trình tiệm tiến gợi ý

Mỗi tuần 1-2 việc, bắt đầu từ mức hiện tại của người dùng:

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Hộ xu bất đổ	Đứng dậy đi lại 2-3 phút sau mỗi giờ ngồi
2	Hộ xu bất đổ	Đi bộ 10 phút sau bữa trưa hoặc tối
3	Khí lực	Đi bộ nhanh 3 buổi × 15-20 phút
4	Cân cốt nhúc	2 buổi bài sức cơ tại nhà × 10 phút
5	Nhu và hoà	Bát đoạn cầm hoặc bài dưỡng sinh buổi sáng 10 phút
6	Trung độ	Đặt 1 ngày nghỉ trong tuần; ghi cảm nhận sau tập
7-12	Khí lực	Tăng dần đến 150 phút/tuần, giữ 2 buổi sức cơ

Hai lối vào theo bốn tầng (lý luận mục II):

- Người **mệt, suy nhược** (Thân, Khí yếu): bắt đầu bằng đi bộ chậm và đạo dẫn nhẹ, không bắt đầu bằng cường độ.
- Người **căng thẳng, bất an** (Tâm, Thần yếu): bắt đầu bằng đạo dẫn có hơi thở (giao với trụ Thiền) hoặc đi bộ trong thiên nhiên.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

- Đối chiếu nguyên văn: lời Hoa Đà (*Tam quốc chí*), Lã Thị Xuân Thu, *Dị pháp phương nghi luận*, *Tuyên minh ngũ khí*, *Thượng cổ thiên chân luận*, *Tứ khí điều thần đại luận*; xuất xứ "đạo khí lệnh hoà, dẫn thể lệnh nhu", "bách bộ tẩu".
- Ánh xạ cân - cốt - nhục với Can - Thận - Tỳ cho từng phẩm chất vận động.
- Tư liệu gốc phương pháp dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng; nội dung về vận động trong Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông.
- Gợi ý vận động theo tiết khí, có điều chỉnh cho miền Nam.

Bác sĩ, chuyên gia phục hồi chức năng, y học thể thao:

- Bộ sàng lọc trước vận động (PAR-Q+ bản tiếng Việt, bản quyền).
- Cờ đỏ, khoá theo bệnh, ngưỡng huyết áp.
- Thư viện bài tập: biên soạn, trình diễn, mức độ cho từng nhóm (người cao tuổi, thai kỳ, dân văn phòng).
- Quy tắc tăng tiến, bài kiểm tra định kỳ và ngưỡng tham chiếu cho người Việt.
- Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.

Chuyên gia tâm lý:

- Cách nhắc nhở không gây mặc cảm; dấu hiệu vận động cưỡng bức.

Trụ Thiền

Hành chủ đạo: Kim

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Đông lý, Tây chứng, tầng được nuôi, trong app**.

Trụ Thiền có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm. Nhóm A đi theo phép **"tam điều"** cổ truyền: điều thân, điều tức, điều tâm.

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Tam điều	Thiền gồm những gì	1. Điều tức: hơi thở · 2. Điều thân: tư thế, thả lỏng · 3. Điều tâm: chú tâm, định
B. Quán	Thiền đưa đến đâu	4. Quán chiếu: nhận biết và buông, lòng tử tế với chính mình
C. Cách thực hành	Thiền thế nào trong đời sống	5. Thiền trong đời thường · 6. Liều lượng và thời điểm

Nền chung là **cơ chế gốc: tĩnh thì thần tàng**.

Hành chủ đạo: Kim (Phế chủ khí, chủ hô hấp; Kim tính thu liễm). **Tặng cùng tham gia:** tạng Tâm (tàng thần, chủ tình chí), Thận (tàng tinh, tàng chí). Việc gán hành là ☯.

Lập trường: thiền thế tục, tôn trọng mọi tín ngưỡng 🙏

Thiền có gốc sâu trong Phật giáo, Đạo gia và văn hoá Việt. Trong Lục Dưỡng, thiền được trình bày như **một phép dưỡng sinh thế tục**: rèn sự chú tâm, hơi thở và sự bình an.

- Không yêu cầu người dùng theo tôn giáo nào. Người theo Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo hay không tôn giáo đều thực hành được.
- Khi nhắc nguồn gốc (Thiền Trúc Lâm, Làng Mai), nói với **thái độ trân trọng di sản**, không truyền giáo.
- Không dùng thiền để hứa hẹn những điều thuộc tâm linh hay siêu nhiên.

Cơ chế gốc: tĩnh thì thần tàng

Đông lý

- Tổ Vấn, "Thượng cổ thiên chân luận":* **"Điểm đạm hư vô, chân khí tàng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tàng lai"**: lòng điểm đạm, trống rỗng, thì chân khí thuận theo; tinh thần giữ ở bên trong, thì bệnh từ đâu mà đến.

- Cùng thiên mô tả bậc chân nhân **"hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần"**: thở hít tinh khí, đứng vững mà giữ thần.
- *Tổ Vĩn, "Tý luận"*: **"Âm khí giả, tĩnh tắc thần tàng, táo tắc tiêu vong"**: âm khí, tĩnh thì thần được tàng giữ, xao động thì hao mất.
- Tuệ Tĩnh: **"tồn thần, thanh tâm"** nằm trong bảy phép dưỡng sinh.

Chuỗi Đông lý: tâm tĩnh → thần được tàng ở tạng Tâm → thần ngự khí (khí thuận) → khí nhiếp tinh (tinh không hao) → thân an. Đây chính là **chiều dẫn dắt từ trên xuống** trong bốn tầng của lý luận (mục II).

Ngược lại, tâm xao động, lo nghĩ triền miên thì thần không yên, khí loạn, tinh hao. *Linh Khu, "Khẩu vấn"*: "Tâm động thì ngũ tạng lục phủ đều lay động".

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Căng thẳng kéo dài hoạt hoá trục dưới đồi – tuyến yên – thượng thận và hệ giao cảm; liên quan tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ, suy giảm miễn dịch	Tâm động thì ngũ tạng đều lay động	C1
Thiền chánh niệm giảm căng thẳng, lo âu, triệu chứng trầm cảm ở mức nhỏ đến vừa. Phân tích gộp của Goyal và cộng sự (JAMA Internal Medicine 2014): bằng chứng vừa phải cho lo âu, trầm cảm, đau; không tốt hơn các liệu pháp tích cực khác như tập thể dục hay trị liệu tâm lý	Điểm đạm hư vô, chân khí tòng chi	C1 (hiệu quả nhỏ – vừa)
Liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm (MBCT) giảm nguy cơ tái phát trầm cảm ở người đã từng trầm cảm nhiều lần (phân tích gộp của Kuyken và cộng sự 2016)	Sái hậu phòng phục	C1
Thay đổi cấu trúc, hoạt động não ở người thiền lâu năm	Thần được tàng	C2-C3 (kết quả chưa nhất quán)
Thiền làm chậm lão hoá tế bào (telomere)	Bệnh an tông lai	C3

Hệ quả cho app 🍷

Mọi lời khuyên trả lời một câu: **việc này giúp tâm lắng xuống hay làm tâm xao động thêm?** Tín hiệu tự cảm nhận: **hơi thở chậm và êm hơn, vai cổ thả lỏng, ít bị cuốn vào suy nghĩ, dễ quay lại việc đang làm.**

Thông điệp trung thực: thiền là **phép dưỡng có lợi, hiệu quả vừa phải**, không phải phép màu và **không thay thế điều trị** trầm cảm, lo âu.

A. Tam điều

Phép **điều thân, điều tức, điều tâm** được hệ thống trong các sách tọa thiền cổ (thường dẫn *Tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu* của Trí Khải đại sư; cần xác định xuất xứ). Thứ tự này cũng là thứ tự dễ học nhất: **thân yên trước, hơi thở theo sau, tâm lắng sau cùng**.

Cơ chế 1. Điều tức: hơi thở

Đông lý.

- Phế chủ khí, chủ hô hấp; Phế thuộc Kim, tính thu liễm.** Thở chậm, sâu, êm là cách trực tiếp nhất để thu liễm khí đang tán loạn.
- Trang Tử, "Khắc ý": "Xuy hư hô hấp, thổ cố nạp tân":* thở ra cái cũ, hít vào cái mới. (*Cần đối chiếu.*)
- Đạo gia dạy thở xuống **đan điền**, tức vùng bụng dưới; Thận chủ nạp khí, nên thở sâu xuống bụng gắn với Thận ☯.
- Phật giáo có *Kinh Quán niệm hơi thở* (Anapanasati): biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra. Đây là nền của phép thiền hơi thở trong truyền thống Làng Mai.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Thở chậm (khoảng 6 nhịp/phút) tăng biến thiên nhịp tim, tăng hoạt động phó giao cảm (hệ "nghỉ ngơi và tiêu hoá")	C2
Thở ra dài hơn hít vào hỗ trợ cảm giác thư giãn	C2
Bài tập thở có kiểm soát giảm lo âu, căng thẳng tự báo cáo; một thử nghiệm nhỏ (Balban và cộng sự 2023) thấy bài "thở dài theo chu kỳ" 5 phút/ngày cải thiện tâm trạng	C2
Thở chậm có thể hạ huyết áp nhẹ	C2
Thở nhanh, sâu kéo dài (tăng thông khí) gây chóng mặt, tê tay; nín thở lâu trong nước có thể gây ngất, đuối nước	C1 (về nguy cơ)

Tăng được nuôi: Khí ●●●, Tâm ●●.

Trong app:

- Bài thở nền ☯: **"thở bốn - sáu"**: hít vào khoảng 4 nhịp đếm, thở ra khoảng 6 nhịp đếm, trong 3-5 phút. Có vòng tròn hoặc âm thanh dẫn nhịp.
- Bài **"ba hơi thở"** ☯: dừng lại, thở chậm ba hơi trước khi trả lời tin nhắn, trước cuộc họp. Ngăn đến mức ai cũng làm được.
- Không đưa vào** các kỹ thuật thở nhanh mạnh kéo dài hoặc nín thở lâu ở phiên bản đầu.
- Người dùng tự chọn: thở tự nhiên và chỉ quan sát, hoặc theo nhịp dẫn. Một số người thấy khó chịu khi bị "điều khiển" hơi thở.

Cơ chế 2. Điều thân: tư thế và thả lỏng

Đông lý.

- Ngồi thẳng mà không cứng: "**hư linh đỉnh kinh, hàm hung bạt bối**" (đỉnh đầu như treo nhẹ, ngực hơi thu, lưng thẳng) là yếu lĩnh tư thế trong Thái cực và thiền. (Xuất xứ cần xác định.)
- **Hình chính thì khí thuận**: thân ngay ngắn thì khí lưu thông, thân co gập thì khí trệ.
- Tư thế không bắt buộc ngồi kiết già: ngồi ghế, đứng, nằm đều có thể thiền.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Thư giãn cơ tăng tiến (căng rồi thả từng nhóm cơ) giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ	C1-C2
Quét cơ thể (body scan) là thành phần của chương trình MBSR, giúp nhận biết căng thẳng trong cơ thể	C2
Căng cơ vùng cổ vai kéo dài liên quan căng thẳng tâm lý và đau	C2

Tầng được nuôi: Thân ●, Khí ●, Tâm ●●.

Trong app:

- Bài "**quét thân**" 5-10 phút: đưa sự chú ý lần lượt từ đỉnh đầu đến bàn chân, thả lỏng chỗ đang căng.
- Bài "**thả vai**" 1 phút cho dân văn phòng: nhún vai lên, giữ, thả xuống, kết hợp thở ra dài. Nối với nhắc "đứng dậy" của trụ Luyện tập.
- Hướng dẫn tư thế linh hoạt: ngồi ghế, ngồi bệt, nằm (trước khi ngủ). Người đau lưng, người cao tuổi **không cần ngồi xếp bằng**.

Cơ chế 3. Điều tâm: chú tâm và định

Đông lý.

- "**Tinh thần nội thủ**": giữ tinh thần ở bên trong, không để chạy theo ngoại cảnh.
- Phật giáo gọi là **chỉ** (samatha): dừng tâm lại trên một đối tượng (hơi thở, âm thanh, một câu niệm) cho đến khi tâm **định**.
- Tâm chạy theo suy nghĩ triền miên là "**tư**" thái quá, mà "**tư thương Tỳ**" (lý luận mục VI): lo nghĩ quá thì hại Tỳ, ăn không ngon, ngủ không yên.

Chuỗi Đông lý: tâm tán loạn → giữ tâm trên một điểm → tâm dần lắng → thần sáng, tư lự giảm → Tỳ không bị tổn, khí không bị loạn.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Tâm lang thang là trạng thái rất phổ biến và liên quan tâm trạng thấp hơn (Killingsworth và Gilbert 2010, nghiên cứu quan sát)	C2
Thiền chánh niệm giảm suy nghĩ lặp đi lặp lại (nghiền ngấm, lo lắng), một cơ chế quan trọng của trầm cảm và lo âu	C2
Thiền cải thiện một số khía cạnh của sự chú ý; mức độ và độ bền vững của tác dụng còn tranh luận	C2
Mạng lưới chế độ mặc định của não (hoạt động khi tâm lang thang) giảm hoạt động khi thiền	C2–C3

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●●.

Trong app:

- Bài **"đếm hơi thở"** 🌬️: đếm từ 1 đến 10 theo mỗi hơi thở ra, lạc thì quay về 1. Không chê trách khi lạc: **nhận ra mình lạc là một lần tập thành công**.
- Lựa chọn đối tượng chú tâm: hơi thở, âm thanh xung quanh, cảm giác bàn chân, hoặc một câu ngắn người dùng tự chọn (có thể là câu cầu nguyện theo tín ngưỡng riêng).
- Không hứa "tâm trống rỗng". Mục tiêu là **nhận ra và quay về**, không phải không có suy nghĩ.

B. Quán

Cơ chế 4. Quán chiếu: nhận biết, buông, và lòng tử tế

Đông lý.

- Phật giáo gọi là **quán** (vipassana): sau khi tâm định, quan sát cảm xúc, suy nghĩ đến rồi đi mà không bám theo.
- Trần Nhân Tông, *Cư trần lạc đạo phú*: **"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên"**: sống giữa đời mà vui với đạo, hãy tùy duyên. Đây là tinh thần **Thiền Trúc Lâm**: thiền không tách khỏi đời sống. (*Cần đối chiếu nguyên văn.*)
- **Điểm chạm hư vô**: không phải vô cảm, mà là không để cảm xúc thái quá chiếm lấy (thất tình thái quá mới thành bệnh).
- Truyền thống Phật giáo có phép **từ bi quán**: nuôi lòng thương với mình và người.

Chuỗi Đông lý: cảm xúc khởi lên → nhận biết, gọi tên, không bám không đẩy → cảm xúc tự qua → không thành thất tình thái quá → năm tạng không bị tổn. Đây là chỗ trụ Thiền **phòng giữ nội nhân** (lý luận mục VI), cùng với trụ Cảm xúc.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Gọi tên cảm xúc giảm cường độ phản ứng cảm xúc (nghiên cứu thực nghiệm về "gọi tên cảm xúc")	C2

Hiện tượng	Cấp
Khả năng nhìn suy nghĩ như suy nghĩ, không như sự thật (tách bạch, decentering) là cơ chế giải thích tác dụng của MBCT	C2
Thực hành lòng trắc ẩn với bản thân (self-compassion) giảm tự phê phán, trầm cảm, lo âu	C2
Thiền từ bi (loving-kindness) tăng cảm xúc tích cực, cảm giác kết nối	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Thân ●●.

Trong app:

- Bài "**gọi tên cảm xúc**" 🕒 3 phút: dừng lại, thở, tự hỏi "mình đang cảm thấy gì?", chọn tên từ bánh xe cảm xúc. Nối thẳng với nhật ký của trụ Cảm xúc.
- Bài "**thương mình**" 🕒 5 phút, câu chữ thể tục: "Mong mình được bình an. Mong mình được khoẻ mạnh. Mong mình đối xử dịu dàng với chính mình."
- Không đẩy người dùng vào việc đào sâu ký ức đau buồn. Quán trong app dừng ở **nhận biết cảm xúc hiện tại**.

C. Cách thực hành

Cơ chế 5. Thiền trong đời thường

Đông lý.

- Thiền Trúc Lâm: **thiền giữa đời**, không cần lên núi.
- Truyền thống Làng Mai (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) phổ biến **thiền đi, thiền ăn, thiền rửa bát, chuông chánh niệm**: mọi việc thường ngày đều là dịp thực hành.
- **Đạo dẫn** (trụ Luyện tập, cơ chế 4) là "thiền động": động tác chậm cùng hơi thở và chú tâm.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Các thực hành chánh niệm ngắn, rải trong ngày (chánh niệm không chính thức) có liên quan với giảm căng thẳng, dù bằng chứng yếu hơn thiền chính thức	C2
Thói quen gắn với tín hiệu có sẵn trong ngày (gắn thói quen mới vào thói quen cũ) dễ duy trì hơn	C2
Đi bộ trong thiên nhiên giảm căng thẳng tự báo cáo	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thân ●.

Trong app:

- "**Chuông chánh niệm**" 🕒: vài lần trong ngày (người dùng chọn giờ, có thể tắt), điện thoại phát một tiếng chuông nhẹ, nhắc dừng lại thở ba hơi.
- **Gắn thiền vào việc có sẵn** 🕒: ba hơi thở trước bữa ăn (nối trụ Ăn uống, "ba miếng đầu chánh niệm"), thiền đi trên đường đến chỗ làm, thở chậm khi chờ đèn đỏ (chỉ khi

dùng xe an toàn).

- **Không gọi ý thiền khi đang lái xe**, vận hành máy móc, hay ở nơi cần tỉnh táo.

Cơ chế 6. Liều lượng và thời điểm

Đông lý.

- **Tiệm tiến** (pháp tắc 6): ít mà đều hơn nhiều mà bỏ.
- **Thuận thời**: sáng sớm thanh khí lên, dễ định tâm; tối trước khi ngủ, thiền giúp **"tâm yên thì ngủ"** (tạng Tâm và giấc ngủ, trụ Ngủ nghỉ).
- **Trung độ**: ngồi quá lâu, ép tâm quá mức cũng là thái quá. Trong truyền thống thiền có hiện tượng **"tẩu hoả nhập ma"** để chỉ những rối loạn khi tu tập sai cách hoặc quá sức. *(Lục D dưỡng không dùng cụm này với người dùng, chỉ ghi nhận như kinh nghiệm cổ truyền về rủi ro.)*

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Thực hành ngắn (khoảng 10 phút/ngày) đã có tác dụng trên căng thẳng tự báo cáo; tác dụng tăng theo sự đều đặn	C2
Chương trình chuẩn MBSR kéo dài 8 tuần, mỗi tuần một buổi nhóm và thực hành tại nhà khoảng 45 phút/ngày	C1 (về cấu trúc chương trình)
Thiền không phải lúc nào cũng dễ chịu. Một tỷ lệ người thực hành gặp tác dụng không mong muốn (lo âu tăng, ký ức đau buồn trở dậy, cảm giác tách rời bản thân); nguy cơ cao hơn khi thực hành cường độ cao, khoá tu dài ngày, hoặc ở người có tiền sử rối loạn tâm thần (Britton và cộng sự 2021)	C2
Thiền chánh niệm cải thiện chất lượng giấc ngủ ở mức vừa; với mất ngủ mạn tính , liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ (CBT-I) mới là điều trị hàng đầu	C1 (CBT-I) / C2 (thiền)

Tăng được nuôi: bảo vệ cả bốn tầng; chủ yếu Tâm ● và Thân ●.

Trong app:

- Liều khởi đầu: **3-5 phút/ngày**. Tăng dần đến 10-20 phút nếu người dùng muốn. **Không thách thức kiểu "thiền 60 phút"**.
- Hai khung giờ gợi ý: **sáng** (định tâm cho ngày mới) và **trước ngủ** (bài thở, quét thân, nối trụ Ngủ nghỉ).
- Đếm **số ngày có thực hành**, không đếm chuỗi ngày liên tục ("streak") theo kiểu gây áp lực; lỡ một ngày không bị "mất chuỗi".
- Không tổ chức khoá tu dài ngày, thiền cường độ cao trong phiên bản đầu. Nếu có, cần người hướng dẫn có chuyên môn và sàng lọc.

Tổng hợp: trụ Thiền nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực
0. Tĩnh thì thần tàng (nền)		●●	●●	●●●	(khung giải thích)
1. Điều tức		●●●	●●		Thở chậm, thở ra dài [C2]
2. Điều thân	●	●	●●		Quét thân, thư giãn cơ [C1-C2]
3. Điều tâm			●●	●●●	Đếm hơi thở; nhận ra và quay về [C2]
4. Quán chiếu			●●●	●●	Gọi tên cảm xúc; thương mình [C2]
5. Thiền đời thường			●●	●	Chuông chánh niệm; gắn vào việc có sẵn [C2]
6. Liều lượng, thời điểm			●	●	Ngắn mà đều; sáng và trước ngủ [C2]

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Thiền: Khí ●●, Tâm ●●, Thần ●●●). Khác với trụ Ăn uống và Luyện tập, phần lớn lời khuyên của trụ Thiền ở **cấp C2**; chỉ có tác dụng chung trên lo âu, trầm cảm và MBCT phòng tái phát ở cấp C1. Khi truyền thông cần nói đúng mức.

Thiền tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Thiền → Ngủ nghỉ	Kim sinh Thủy: thở chậm, tĩnh tâm thì dễ ngủ; tác động lên giấc ngủ ở mức vừa	C2
Ăn uống → Thiền	Thổ sinh Kim: ăn uống điều độ, không no căng thì dễ ngồi yên; ăn chánh niệm là cầu nối	C3 (vòng sinh) / C2 (ăn chánh niệm)
Thiền ↔ Cảm xúc	Quán chiếu, gọi tên cảm xúc phòng thất tình thái quá	C2
Thiền ↔ Luyện tập	Đạo dẫn, Thái cực, yoga là "thiền động"	C2
Thiền → Môi trường xã hội	Thiền từ bi tăng cảm giác kết nối; thiền nhóm tạo cộng đồng	C2
Môi trường → Thiền	Tiếng ồn, không gian chật, thiếu riêng tư làm khó thực hành; thiên nhiên hỗ trợ	C2

Đo lường trụ Thiền 📏

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Tự động

- **Số phút** và **số ngày** thực hành trong app.
- HRV từ đồng hồ (nếu có) **chỉ là dữ liệu tham khảo** cho thư giãn, **không** gọi là "đo Khí", **không** gọi là "đo độ sâu thiền" (lý luận mục II).

Trước và sau mỗi buổi (tùy chọn, 5 giây)

- "Lòng bạn lúc này yên đến đâu?" (0-10), hỏi trước và sau. App chỉ hiển thị xu hướng, không khen chê từng buổi.

Check-in hằng ngày

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Hôm nay bạn có dừng lại thở chậm hoặc thiền không?	Không · Vài hơi thở · 1-10 phút · >10 phút	1, 3, 5
2	Hôm nay bạn có hay bị cuốn vào suy nghĩ, lo lắng không?	Hiếm · Thỉnh thoảng · Thường xuyên	3, 4

Định kỳ (mỗi 2-4 tuần, cần chuyên gia chọn công cụ đã thẩm định tiếng Việt)

- **Thang căng thẳng cảm nhận** (ví dụ PSS-10).
- PHQ-4 và WHO-5 của tầng Tâm, tầng Thần (lý luận mục II) đã bao phủ phần lớn tác dụng của thiền.
- Câu hỏi về **trải nghiệm khó chịu khi thiền** (để phát hiện tác dụng không mong muốn).

Không đo

- Không chấm điểm "độ sâu" hay "chất lượng" buổi thiền.
- Không xếp hạng, không so sánh số phút với người khác.

An toàn riêng cho trụ Thiền

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần chuyên gia tâm lý lâm sàng và bác sĩ tâm thần duyệt.** Đây là trụ có rủi ro tâm lý cao nhất trong sáu trụ, vì đi thẳng vào tầng Tâm và Thần.

Cờ đỏ khẩn cấp

Áp dụng nguyên mục X của lý luận: ý nghĩ tự hại hoặc không muốn sống thì **dừng mọi bài thiền**, hiển thị ngay số cấp cứu 115 và đường dây hỗ trợ tâm lý đã được xác minh.

Dừng buổi thiền và đổi hướng

Dấu hiệu trong hoặc sau buổi thiền	Hành động
Hoảng loạn, tim đập nhanh, khó thở khi chú ý vào hơi thở	Dừng. Mở mắt, nhìn quanh, gọi tên năm thứ nhìn thấy. Gợi ý đổi đối tượng chú tâm (âm thanh, bàn chân) hoặc thiền đi

Dấu hiệu trong hoặc sau buổi thiền	Hành động
Ký ức đau buồn, hình ảnh sang chấn ủa về	Dừng. Bài "neo về hiện tại" (mở mắt, cảm nhận bàn chân chạm đất). Khuyến trao đổi với chuyên gia nếu lặp lại
Cảm giác tách rời bản thân, mọi thứ không thật	Dừng. Neo về hiện tại; khuyến gặp chuyên gia nếu kéo dài
Chóng mặt, tê tay khi tập thở	Dừng bài thở; thở tự nhiên

Cờ đỏ cần đi khám, chuyên gia

Dấu hiệu	Hành động
Tắc dụng khó chịu lặp lại nhiều buổi hoặc kéo dài sau buổi thiền	Tạm dừng các bài thiền dài; khuyến gặp chuyên gia tâm lý
PHQ-4, WHO-5 vượt ngưỡng sàng lọc	Theo mục X của lý luận. Nói rõ thiền không thay thế điều trị
Mất ngủ ≥ 3 đêm/tuần kéo dài ≥ 3 tháng	Khuyến đi khám; CBT-I là điều trị hàng đầu

Khoá và điều chỉnh theo tình trạng

Tình trạng đã khai	Điều chỉnh
Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), tiền sử sang chấn nặng	Chỉ bài ngắn, mở mắt, hướng ra ngoài (âm thanh, chuyển động); không quét thân dài; khuyến thực hành cùng chuyên gia
Rối loạn loạn thần, rối loạn lưỡng cực (nhất là giai đoạn hưng cảm)	Khoá thiền dài, thiền im lặng; chỉ bài thở ngắn; hỏi bác sĩ điều trị
Trầm cảm nặng đang diễn tiến	Chỉ bài ngắn, nhẹ; ưu tiên kết nối điều trị. MBCT thường dành cho giai đoạn đã ổn định
Rối loạn hoảng sợ	Không bắt đầu bằng thiền hơi thở; dùng âm thanh, thiền đi
Động kinh, bệnh tim phổi, thai kỳ	Không dùng kỹ thuật thở nhanh mạnh hoặc nín thở

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🍃

Mỗi tuần **1-2 việc**, bắt đầu từ điều thân và điều tức:

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Điều tức	"Ba hơi thở" 3 lần/ngày, gắn vào bữa ăn
2	Điều tức	"Thở bốn – sáu" 3 phút trước khi ngủ
3	Điều thân	"Quét thân" 5 phút, 3 buổi trong tuần
4	Điều tâm	"Đếm hơi thở" 5 phút buổi sáng
5	Quán chiếu	"Gọi tên cảm xúc" khi thấy căng thẳng
6	Đòi thường	Bật "chuông chánh niệm" 2-3 lần/ngày; một buổi thiền đi

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
7-12	Ổn định	Một bài chính 10-15 phút/ngày, chọn khung giờ hợp mình

Hai lối vào theo bốn tầng (lý luận mục II):

- Người **căng thẳng, bất an** (Tâm, Thần yếu): thiền là cửa vào chính; bắt đầu bằng bài thở ngắn, không bắt đầu bằng ngồi im lâu.
- Người **mệt, suy nhược** (Thân, Khí yếu): thiền nằm, quét thân trước khi ngủ; ưu tiên ăn ngủ trước.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y và người có chuyên môn về Phật học, Đạo học:

- Đối chiếu nguyên văn: *Thượng cổ thiên chân luận, Tý luận, Linh Khu "Khẩu vấn", Trang Tử "Khắc ý", Cư trần lạc đạo phú*; xuất xứ "tam điều" và yếu lĩnh tư thế.
- Cách trình bày Thiền Trúc Lâm, Làng Mai, *Kinh Quán niệm hơi thở* trong khuôn khổ thể tục, tôn trọng.
- Nội dung tôn thần, thanh tâm trong Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông.

Chuyên gia tâm lý lâm sàng, bác sĩ tâm thần:

- Bộ cờ đỏ riêng của thiền; quy trình dừng và neo về hiện tại.
- Khoá theo tình trạng (PTSD, loạn thần, lưỡng cực, trầm cảm nặng, hoảng sợ).
- Thư viện bài thiền: biên soạn, thu âm, độ dài, ngôn ngữ thể tục.
- Thang đo định kỳ (PSS-10 hoặc tương đương) bản tiếng Việt đã thẩm định.
- Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.

Người có chuyên môn hướng dẫn thiền (ví dụ đã qua đào tạo MBSR, MBCT):

- Trình tự bài tập, cách hướng dẫn người mới, cách xử lý trải nghiệm khó.

Trụ Cảm xúc

Hành chủ đạo: Hỏa

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Đông lý, Tây chứng, tầng được nuôi, trong app**.

Trụ Cảm xúc có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Hiểu	Mình đang cảm thấy gì	1. Tri tình: nhận biết, gọi tên cảm xúc
B. Điều	Làm gì với cảm xúc khó	2. Điều tình: nhìn lại, chuyển hướng · 3. Sơ tiết: giải toả căng thẳng, không để uất kết
C. Dưỡng	Nuôi cảm xúc lành	4. Hỷ hoà: niềm vui vừa phải, biết ơn · 5. Tương thân: chia sẻ, được nâng đỡ · 6. Định chí: ý nghĩa, giá trị sống

Nền chung là **cơ chế gốc: tạng Tâm là chủ, thất tình thái quá mới thành bệnh**.

Hành chủ đạo: Hỏa (tạng Tâm điều phối tình chí). **Tạng cùng tham gia:** đủ năm tạng theo ngũ chí. Lập luận ở lý luận v0.3, mục III.

Lập trường

- Không có cảm xúc "xấu"**. Giận, buồn, sợ đều là phản ứng tự nhiên và có ích. Cổ truyền cũng chỉ coi là bệnh khi **thái quá** hoặc **kéo dài**.
- Không ép "luôn tích cực"**. Bắt người đang buồn phải vui là trái với "hoà hỷ nộ".
- Trụ Cảm xúc không phải trị liệu tâm lý**. App đồng hành ở mức dưỡng sinh hằng ngày; khi vượt ngưỡng thì chuyển tiếp đến chuyên gia.

Cơ chế gốc: tạng Tâm là chủ, thất tình thái quá mới thành bệnh

Đông lý

- Linh Khu*, "Tà khách": tạng Tâm là **"ngũ tạng lục phủ chi đại chủ"**.
- Linh Khu*, "Khẩu vấn": **"Bi ai sầu ưu tắc tâm động, tâm động tắc ngũ tạng lục phủ giai dao"**.

- *Linh Khu, "Bản thân"*: người trí dưỡng sinh thì **"hoà hỷ nộ"**: điều hoà vui giận, không triệt tiêu.
- *Tổ Vĩn, "Cử thống luận"* mô tả cảm xúc làm khí đổi hướng: **"Nộ tắc khí thượng, hỷ tắc khí hoãn, bi tắc khí tiêu, khùng tắc khí hạ, kinh tắc khí loạn, tư tắc khí kết"**: giận thì khí bốc lên, vui thì khí hoà hoãn, buồn thì khí tiêu hao, sợ thì khí đi xuống, hoảng thì khí rối loạn, lo nghĩ thì khí kết lại.
- Ngũ chí và tạng (lý luận mục VI): **nộ thương Can, hỷ thương Tâm, tư thương Tỳ, ưu bi thương Phế, kinh khùng thương Thận**.

Chuỗi Đông lý: sự việc → cảm xúc khởi lên ở tạng Tâm → vừa phải thì khí vận hành bình thường, qua đi → thái quá hoặc kéo dài thì khí đổi hướng (thượng, tiêu, hạ, loạn, kết) → tổn tạng riêng theo ngũ chí → biểu hiện ra thân (mất ngủ, ăn kém, đau đầu, tức ngực).

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Cảm xúc kèm phản ứng sinh lý (nhịp tim, huyết áp, hơi thở, tiêu hoá, cơ bắp)	Cảm xúc làm khí đổi hướng	C1
Căng thẳng mạn tính liên quan tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tiêu hoá chức năng, giảm miễn dịch	Thất tình kéo dài tổn tạng phủ	C1 (liên quan)
Giận dữ dữ dội có thể khởi phát biến cố tim mạch trong vài giờ ở người có nguy cơ	Nộ tắc khí thượng	C2
Căng thẳng tác động tiêu hoá qua trục não - ruột (đau bụng, chán ăn hoặc ăn nhiều)	Tư thương Tỳ, tư tắc khí kết	C2
Đau buồn kéo dài liên quan suy giảm sức khoẻ; "hội chứng trái tim tan vỡ" (bệnh cơ tim do căng thẳng)	Bi tắc khí tiêu; hỷ, bi thương Tâm	C1 (hội chứng có thật, hiếm)
Mỗi chí gắn đúng một tạng	(ngũ chí - ngũ tạng)	C3

Đặc điểm văn hoá Việt

- Nhiều người Việt **diễn tả cảm xúc bằng lời của thân**: "tức ngực", "nặng lòng", "nóng ruột", "mệt trong người", "đau đầu vì lo". Đây là cầu nối tự nhiên giữa ngôn ngữ cổ truyền (cảm xúc biểu hiện ra thân) và trải nghiệm của người dùng.
- Vẫn còn **ngại nói về sức khoẻ tâm lý**, sợ bị coi là "có vấn đề thần kinh". App nên dùng ngôn ngữ dưỡng sinh nhẹ nhàng, không gắn nhãn bệnh.

Hệ quả cho app

Mọi lời khuyên trả lời một câu: **cảm xúc này đang vừa phải và qua đi, hay đang thái quá, kéo dài?** Tín hiệu tự cảm nhận: **cảm xúc đến rồi đi, không kệt lại nhiều ngày; không bị cảm xúc kéo làm điều hối hận; thân không mang theo căng thẳng**.

A. Hiểu

Cơ chế 1. Tri tình: nhận biết và gọi tên cảm xúc

Đông lý. Muốn "hoà hỷ nộ" thì trước hết phải **biết mình đang hỷ hay nộ**. Ngũ chí cho một bản đồ đơn giản để nhận biết 🗺️:

Chí	Cảm xúc hiện đại gần nhất	Khí	Tạng	Thân thường thấy
Nộ	Giận, bực bội, ầm ức	Thượng (bốc lên)	Can	Nóng mặt, đau đầu, tức sườn
Hỷ (thái quá)	Phấn khích quá mức, kích động	Hoãn (tán)	Tâm	Hồi hộp, khó tập trung, khó ngủ
Tư	Lo nghĩ, nghiền ngẫm	Kết	Tỳ	Ăn không ngon, đầy bụng, mệt
Ưu, bi	Buồn, lo âu, đau buồn	Tiêu	Phế	Thở dài, hụt hơi, nặng ngực
Khủng, kinh	Sợ, hoảng	Hạ, loạn	Thận	Tim đập nhanh, run, mót tiểu, mất ngủ

Bảng này là **công cụ gợi ý để tự nhận biết** [C3 về liên hệ tạng]. Không dùng để chẩn đoán.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Gọi tên cảm xúc bằng lời làm giảm cường độ phản ứng cảm xúc (nghiên cứu thực nghiệm về "affect labeling", Lieberman và cộng sự 2007)	C2
Phân biệt cảm xúc chi tiết (biết mình "thất vọng" chứ không chỉ "khó chịu") liên quan khả năng điều tiết tốt hơn	C2
Khó nhận biết, gọi tên cảm xúc liên quan nhiều triệu chứng cơ thể không rõ nguyên nhân	C2
Ghi nhật ký tâm trạng giúp nhận ra quy luật (giờ, sự việc, người)	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Thần ●.

Trong app:

- **Check-in tâm trạng hai bước** 🗺️: (1) "Lòng hôm nay yên đến đâu?" (0-10, check-in tạng Tâm); (2) chọn 1-3 cảm xúc từ **bánh xe cảm xúc tiếng Việt** (vui, bình yên, biết ơn, buồn, lo, giận, sợ, cô đơn, mệt mỏi, xấu hổ...).
- **Lối vào bằng thân** 🗺️ cho người khó gọi tên cảm xúc: "Hôm nay thân bạn thấy thế nào? tức ngực · nặng đầu · nóng ruột · bồn chồn · nhẹ nhõm". App gợi ý cảm xúc có thể đi kèm.
- Sau 2-4 tuần, app cho người dùng **xem quy luật của chính mình** (ví dụ "bạn hay thấy lo vào tối Chủ nhật"), dùng ngôn ngữ "có vẻ như" (lý luận mục IX, bậc 1).

B. Điều

Cơ chế 2. Điều tình: nhìn lại và chuyển hướng

Đông lý.

- Tố Vấn, "Âm dương ứng tượng đại luận" nêu phép **tình chí tương thắng** theo ngũ hành tương khắc: **"bi thắng nộ, khùng thắng hỷ, nộ thắng tư, hỷ thắng ưu, tư thắng khùng"**. Danh y đời sau (như Trương Tử Hoà) có nhiều bệnh án dùng cảm xúc này để chữa cảm xúc kia.
- Tinh thần chung: **không đè nén, mà chuyển hoá**. Cảm xúc là dòng khí, cần được dẫn đi chỗ khác chứ không chặn lại.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Đánh giá lại (nhìn sự việc theo cách khác) là chiến lược điều tiết cảm xúc hiệu quả, liên quan sức khoẻ tâm thần tốt hơn	C1-C2
Đề nén biểu hiện cảm xúc kéo dài liên quan căng thẳng sinh lý cao hơn và kết nối xã hội kém hơn	C2
Hoạt hoá hành vi (lên lịch làm việc có ý nghĩa, dễ chịu dù chưa có hứng) là liệu pháp hiệu quả cho trầm cảm	C1
Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) hiệu quả cho trầm cảm, lo âu	C1
Tình chí tương thắng theo ngũ hành	C3

Cách nối hai bên ☞: phép "hỷ thắng ưu" (vui thắng buồn) gần với **hoạt hoá hành vi**: làm việc nhỏ đem lại niềm vui để kéo tâm ra khỏi buồn. Phép "tư thắng khùng" (suy xét thắng sợ hãi) gần với **đánh giá lại**: suy nghĩ có cơ sở để giảm nỗi sợ phóng đại. Lục D dưỡng dùng **ngôn ngữ cổ truyền làm hình ảnh [C3]** và **kỹ thuật hiện đại làm nội dung [C1-C2]**.

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Thần ●●.

Trong app:

- Bài "**Nhìn lại**" ☞ 5 phút (dựa trên kỹ thuật CBT, cần chuyên gia biên soạn): việc gì xảy ra → mình nghĩ gì → mình cảm thấy gì → có cách nhìn nào khác không → nếu bạn thân gặp chuyện này, mình sẽ nói gì với họ?
- Bài "**Một việc nhỏ dễ chịu**" ☞ khi buồn: chọn từ danh sách cá nhân (pha ấm trà, gọi điện cho mẹ, tưới cây, nghe một bài hát) và làm ngay trong 10 phút.
- Không tự động hoá phép tương thắng** (ví dụ cố ý làm người dùng sợ để bớt vui). Chỉ dùng như câu chuyện văn hoá.

Cơ chế 3. Sơ tiết: giải toả căng thẳng, không để uất kết

Đông lý.

- **Can chủ sơ tiết:** làm cho khí thông suốt, cảm xúc thư thái. Can khí uất kết thì sinh **"khí uất"** (một trong chín thể chất): hay thở dài, tức sườn, dễ cáu, buồn bực, kinh nguyệt không đều.
- **"Tur tắc khí kết":** lo nghĩ làm khí kết lại.
- Giải uất trong cổ truyền: vận động cho khí thông (trụ Luyện tập, Mộc), nói ra, khóc ra, viết ra, gần thiên nhiên.

Tây chúng.

Hiện tượng	Cấp
Phản ứng căng thẳng cấp là bình thường và có ích; căng thẳng mạn tính, không có lúc hồi phục mới gây hại	C1
Vận động thể lực giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm	C1
Viết bộc lộ cảm xúc (expressive writing, Pennebaker) về sự kiện khó khăn có lợi ích nhỏ cho sức khoẻ tinh thần và thể chất	C2
Chia sẻ với người tin cậy giảm căng thẳng; được nâng đỡ xã hội bảo vệ sức khoẻ	C1-C2
Đặt thời gian lo lắng cố định ("giờ lo lắng") giảm lo âu lan man	C2
Giải quyết vấn đề có cấu trúc giảm căng thẳng do vấn đề thực tế	C1-C2

Phân biệt hai loại căng thẳng 📌:

- **Vấn đề giải quyết được** (công việc, tiền bạc, mâu thuẫn): cần **hành động**: chia nhỏ, lên kế hoạch, nhờ giúp đỡ.
- **Vấn đề chưa giải quyết được** (bệnh tật người thân, mất mát): cần **chấp nhận và chăm sóc mình**: thở, chia sẻ, thiền.

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Khí ●● (khí không uất), Thân ● (bớt biểu hiện ra thân).

Trong app:

- Bài **"Giải uất 10 phút"** 📌: đi bộ nhanh hoặc đạp dẫn (nối trụ Luyện tập), kèm thở ra dài.
- **"Viết ra"** 📌: nhật ký 10 phút về điều đang làm mình nặng lòng; **dữ liệu chỉ lưu trên thiết bị**, người dùng có thể xoá ngay.
- **"Giờ lo lắng"** 📌: ghi lại mỗi lo khi nó đến, hẹn xem lại vào một giờ cố định (ví dụ 19h), không mang lên giường ngủ.
- **"Gỡ rối vấn đề"** 📌: năm bước (vấn đề là gì → các lựa chọn → ưu nhược → chọn một bước nhỏ → làm và xem lại).

C. Dưỡng

Cơ chế 4. Hỷ hoà: niềm vui vừa phải và lòng biết ơn

Đông lý.

- Cửu thống luận: **"Hỷ tắc khí hoà chí đạt, vinh vệ thông lợi"**: vui thì khí hoà, chí thông, khí huyết lưu thông. Vui vừa phải là thuốc bổ.
- Nhưng **"hỷ thương Tâm"**: vui thái quá, phấn khích quá cũng hại.
- Văn hoá Việt: **"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"**; **"tri túc"** (biết đủ) gắn với tinh thần "quả dục" của Tuệ Tĩnh.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Cảm xúc tích cực liên quan sức khoẻ tim mạch tốt hơn và tuổi thọ dài hơn (nghiên cứu quan sát)	C2
Thực hành biết ơn (viết điều biết ơn) tăng nhẹ cảm giác hạnh phúc; hiệu quả nhỏ, không phải trị liệu trầm cảm	C2
Tận hưởng có chú ý (savoring) những khoảnh khắc dễ chịu tăng cảm xúc tích cực	C2
Ép bản thân "phải vui" có thể phản tác dụng	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●.

Trong app:

- "Ba điều tốt"** 📖 cuối ngày: ghi ba điều nhỏ dễ chịu hoặc biết ơn. Tần suất gợi ý 2-3 lần/tuần (làm hằng ngày có thể nhàm, giảm tác dụng).
- "Khoảnh khắc nhỏ"** 🕒: khi đang uống trà, ăn món ngon, nghe con cười, dừng lại 20 giây để tận hưởng (nối trụ Thiền).
- Không hiển thị lời khuyên kiểu "hãy tích cực lên"** khi người dùng ghi nhận buồn, đau buồn. Khi đó app công nhận cảm xúc trước ("Buồn là điều tự nhiên khi...").

Cơ chế 5. Tương thân: chia sẻ và được nâng đỡ

Đông lý.

- Định nghĩa sức khoẻ của Lục Dưỡng có về **hài hoà với con người** (lý luận mục III).
- Văn hoá Việt: **"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"**; **"lá lành đùm lá rách"**: tình làng nghĩa xóm là chỗ dựa cảm xúc.
- Ưu bi thương Phế; "ưu" được giải bớt khi có người cùng gánh 🤝.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Quan hệ xã hội tốt liên quan giảm nguy cơ tử vong; phân tích gộp của Holt-Lunstad và cộng sự (2010) cho thấy mức tác động tương đương các yếu tố nguy cơ lối sống quen thuộc	C1

Hiện tượng	Cấp
Được nâng đỡ xã hội giảm phản ứng căng thẳng và bảo vệ khỏi trầm cảm	C1-C2
Cô đơn liên quan trầm cảm, bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ	C1-C2

Phân công với trụ Môi trường: trụ Môi trường lo **mạng lưới quan hệ** (có ai, gặp bao nhiêu, cộng đồng). Trụ Cảm xúc lo **chất lượng chia sẻ cảm xúc** (có dám nói ra, có được lắng nghe).

Tầng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●.

Trong app:

- **"Người tin cậy"** 📌: người dùng tự ghi 1-3 người có thể chia sẻ khi khó khăn (lưu trên máy). Khi tâm trạng thấp nhiều ngày, app nhắc nhẹ "bạn có muốn nhắn cho ... không?".
- Gợi ý cách **mở lời** và cách **lắng nghe** cho người thân (vì người Việt thường ngại nói "mình đang buồn").
- Không xây mạng xã hội, bảng tin công khai trong phiên bản đầu (dễ so sánh, dễ tổn thương).

Cơ chế 6. Định chí: ý nghĩa và giá trị sống

Đông lý.

- **Thận tàng chí.** "Chí" là ý chí, chí hướng; Thận tinh đầy thì chí vững.
- Tầng **Thần** trong Lục Dưỡng gồm **tĩnh thức, sáng suốt, ý chí** (lý luận mục II).
- Tuệ Tĩnh: **"thủ chân"**, giữ cái gốc thật của mình. Trần Nhân Tông: **"tuỳ duyên"**: sống thuận với hoàn cảnh mà không mất phương hướng 📌.

Chuỗi Đông lý: biết mình sống vì điều gì → chí định → thần có chỗ dựa → cảm xúc đến đi mà không làm lay gốc. Đây là cảm xúc ở **tầng Thần**, chiều dẫn dắt từ trên xuống.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Cảm giác có mục đích sống liên quan giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch (nghiên cứu quan sát, phân tích gộp)	C2
Làm việc phù hợp giá trị bản thân (thành phần của liệu pháp chấp nhận và cam kết, ACT) giảm triệu chứng lo âu, trầm cảm	C1-C2
Lạc quan liên quan sức khoẻ tim mạch tốt hơn	C2

Tầng được nuôi: Thần ●●●, Tâm ●.

Trong app:

- **"Điều quan trọng với tôi"** 📝 (làm một lần, xem lại mỗi quý): chọn 3-5 giá trị (gia đình, sức khoẻ, học hỏi, giúp người, đức tin, sáng tạo...).
- Nối giá trị với **lộ trình sáu trụ**: "Bạn chọn *gia đình* là quan trọng. Ăn tối cùng gia đình là cách nuôi cả trụ Ăn uống lẫn Cảm xúc."
- Không áp đặt giá trị, không dạy đạo lý.

Tổng hợp: trụ Cảm xúc nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực
0. Tâm là chủ (nền)	●	●	●●●	●	(khung giải thích)
1. Tri tình			●●●	●	Gọi tên cảm xúc [C2]
2. Điều tình			●●●	●●	Đánh giá lại; hoạt hoá hành vi [C1-C2]
3. Sơ tiết	●	●●	●●●		Vận động; viết ra; gỡ rối vấn đề [C1-C2]
4. Hỷ hoà			●●	●●	Ba điều tốt; tận hưởng [C2]
5. Tương thân			●●	●	Có người tin cậy [C1]
6. Định chí			●	●●●	Sống theo giá trị [C1-C2]

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Cảm xúc: Tâm ●●●, Thần ●). Đề xuất xem xét nâng **Thần lên ●●** nhờ cơ chế 6 (định chí), và thêm **Khí ●** nhờ cơ chế 3 (sơ tiết, khí không uất).

Cảm xúc tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Luyện tập → Cảm xúc	Mộc sinh Hỏa: vận động cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm	C1
Cảm xúc → Ăn uống	Hỏa sinh Thổ: tâm an thì ăn ngon; căng thẳng gây ăn theo cảm xúc hoặc chán ăn; tư thương Tỳ	C2
Cảm xúc ↔ Ngủ nghỉ	Tâm yên thì ngủ; thiếu ngủ làm cảm xúc dễ bùng nổ, giảm khả năng điều tiết	C1
Thiền ↔ Cảm xúc	Quán chiếu, gọi tên cảm xúc; thiền là công cụ chính của điều tình	C2
Cảm xúc ↔ Môi trường xã hội	Kết nối nâng đỡ cảm xúc; mâu thuẫn gia đình, công việc là nguồn căng thẳng lớn	C1-C2
Cảm xúc → Thân	Căng thẳng kéo dài liên quan tăng huyết áp, đau đầu căng cơ, rối loạn tiêu hoá chức năng	C1-C2

Đo lường trụ Cảm xúc 📝

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Check-in hằng ngày (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Lòng hôm nay yên đến đâu?	0-10 (check-in tầng Tâm)	Nền
2	Hôm nay bạn cảm thấy gì nhiều nhất?	Chọn 1-3 từ bánh xe cảm xúc, hoặc lối vào bằng thân	1
3	Cảm xúc khó hôm nay đã qua chưa?	Đã qua · Vẫn còn · Kéo dài nhiều ngày	Nền, 3

Hàng tuần

- **Đã chia sẻ với ai đó** khi có chuyện khó chưa? (Có · Không · Không có chuyện khó)
- **Ba điều tốt** (số lần thực hành).

Định kỳ

- **PHQ-4** mỗi 2 tuần (đã có trong tầng Tâm, lý luận mục II).
- **WHO-5** mỗi 2 tuần (tầng Thân).
- Thang căng thẳng cảm nhận (PSS-10) mỗi 4 tuần, nếu chuyên gia đồng ý.

Không đo

- Không chấm điểm "trí tuệ cảm xúc", không xếp loại tính cách.
- Không phân tích văn bản nhật ký của người dùng bằng AI trong phiên bản đầu (dữ liệu rất nhạy cảm).

An toàn riêng cho trụ Cảm xúc

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần chuyên gia tâm lý lâm sàng và bác sĩ tâm thần duyệt.** Đây là trụ gần nhất với sức khỏe tâm thần.

Cờ đỏ khẩn cấp: dừng mọi lời khuyên

Dấu hiệu	Hành động
Ý nghĩ tự hại, không muốn sống (từ check-in, PHQ, hay từ khoá trong nhật ký nếu người dùng đồng ý quét)	Dừng mọi nội dung dưỡng sinh. Hiển thị số cấp cứu 115 và đường dây hỗ trợ tâm lý đã được xác minh tại Việt Nam. Khuyến khích liên hệ người thân tin cậy (cơ chế 5)
Đang bị bạo lực, bị đe dọa an toàn	Hiển thị đường dây hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình đã được xác minh và số 113 (công an)

Cờ đỏ cần gặp chuyên gia

Dấu hiệu	Hành động
PHQ-4, WHO-5 vượt ngưỡng sàng lọc	Khuyến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý. Nói rõ trầm cảm, lo âu là bệnh chữa được , không phải yếu đuối
Tâm trạng thấp, mất hứng thú gần như mỗi ngày từ 2 tuần trở lên	Như trên
Lo âu, hoảng sợ làm ảnh hưởng công việc, sinh hoạt	Như trên
Đau buồn sau mất mát kéo dài rất lâu, không thể sinh hoạt bình thường	Khuyến gặp chuyên gia (đau buồn kéo dài có hỗ trợ hiệu quả)
Dùng rượu, chất kích thích để đối phó cảm xúc	Khuyến gặp chuyên gia; nói cờ đỏ rượu ở trụ Ăn uống
Giai đoạn hưng phấn bất thường: ngủ rất ít mà không mệt, nói nhiều, tiêu tiền bốc đồng	Khuyến gặp bác sĩ tâm thần

Nguyên tắc nói chuyện 📌

- **Công nhận trước, gợi ý sau.** Không nói "đừng buồn", "nghĩ tích cực lên".
- **Không gán nhãn bệnh.** App không nói "bạn bị trầm cảm"; nói "kết quả cho thấy bạn nên trao đổi với chuyên gia".
- **Không thay thế điều trị.** Người đang điều trị tâm thần: các bài tập trong app là **hỗ trợ**, không thay thuốc hay trị liệu; nhắc **không tự ý ngưng thuốc**.
- **Riêng tư tuyệt đối** với nhật ký cảm xúc: mặc định lưu trên thiết bị, mã hoá, xoá được.

Khoá và điều chỉnh

Tình trạng	Điều chỉnh
Đang điều trị tâm thần	Bài tập ở mức hỗ trợ; nhắc trao đổi với người điều trị
Mới trải qua sang chấn, mất mát lớn	Không gợi ý "biết ơn", "nhìn lại tích cực"; ưu tiên chăm sóc, chia sẻ, chuyên gia
Dưới 18 tuổi	Không phải đối tượng của phiên bản đầu

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 📌

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Tri tình	Check-in tâm trạng hai bước mỗi tối
2	Tri tình	Thêm "lối vào bằng thân" khi khó gọi tên cảm xúc
3	Sơ tiết	"Giải uất 10 phút" khi căng thẳng; thử "giờ lo lắng"
4	Điều tình	Bài "Nhìn lại" một lần trong tuần
5	Hỷ hoà	"Ba điều tốt" 2-3 lần/tuần

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
6	Tương thân	Ghi tên "người tin cậy"; chủ động hỏi thăm một người
7-12	Định chí	"Điều quan trọng với tôi"; chọn việc nhỏ hằng tuần gắn với giá trị

Hai lối vào theo bốn tầng:

- Người **căng thẳng, bất an** (Tâm, Thần yếu): bắt đầu từ cơ chế 3 (sơ tiết) và trụ Thiền.
- Người **mệt mỏi kéo dài, mất hứng thú**: chạy kiểm tra cờ đỏ trước (có thể là trầm cảm); sau đó hoạt hoá hành vi nhẹ nhàng (cơ chế 2) và trụ Luyện tập.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

1. Đối chiếu nguyên văn: *Cử thống luận, Âm dương ứng tượng đại luận, Linh Khu "Tà khách", "Khẩu vấn", "Bản thân".*
2. Bảng ngũ chí - khí - tạng - biểu hiện thân; thể chất Khí uất và cách dưỡng.
3. Bệnh án tình chí tương thắng (Trương Tử Hoà, danh y Việt) dùng làm câu chuyện văn hoá.

Chuyên gia tâm lý lâm sàng, bác sĩ tâm thần:

1. Bánh xe cảm xúc tiếng Việt; "lối vào bằng thân".
2. Nội dung các bài "Nhìn lại", "Gỡ rối vấn đề", "Giờ lo lắng", "Viết ra" (dựa trên CBT, ACT).
3. Bộ cờ đỏ, ngưỡng PHQ-4, WHO-5, quy trình chuyển tuyến, các đường dây hỗ trợ đã xác minh.
4. Nguyên tắc ngôn ngữ; xử lý khi người dùng đang điều trị.
5. Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.

Pháp lý:

1. Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu nhật ký cảm xúc.

Trụ Ngủ nghỉ

Hành chủ đạo: Thuỷ

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Đông lý**, **Tây chứng**, **tầng được nuôi**, **trong app**.

Trụ Ngủ nghỉ có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Giấc ngủ	Ngủ bao nhiêu, lúc nào	1. Túc miên: ngủ đủ · 2. Thuận thời: giờ đều, ánh sáng đúng lúc, giấc trưa
B. Điều kiện để ngủ	Vì sao ngủ không ngon	3. Tâm yên thì ngủ · 4. Vị hoà thì ngủ · 5. Chỗ ngủ yên
C. Nghỉ	Nghỉ ngơi ban ngày	6. Bất vọng tác lao: nghỉ giữa giờ, ngày nghỉ, hồi phục

Nền chung là **cơ chế gốc: âm dương giao thì ngủ**.

Hành chủ đạo: Thuỷ (Thận tàng; giấc ngủ là "mùa đông của một ngày"). **Tạng cùng tham gia:** tạng Tâm (thần yên thì ngủ), Can ("*nhân ngọa huyết quy ư Can*"), Tỳ Vị. Việc gán hành là ☵.

Cơ chế gốc: âm dương giao thì ngủ

Đông lý

- Linh Khu*, "*Khẩu vấn*" giải thích ngủ và thức bằng sự vận hành của dương khí và âm khí: **dương khí hết, âm khí thịnh thì mắt nhắm (ngủ); âm khí hết, dương khí thịnh thì tỉnh dậy**. (*Cần đối chiếu nguyên văn.*)
- Linh Khu* (các thiên "Doanh vệ sinh hội", "Đại hoặc luận") mô tả **vệ khí ban ngày đi ở phần dương, ban đêm vào phần âm**; vệ khí vào âm thì ngủ, ra dương thì thức. (*Cần đối chiếu.*)
- Tổ Vấn*, "*Ngũ tạng sinh thành*": "**Nhân ngọa huyết quy ư Can**": người nằm thì huyết về Can. Ngủ là lúc huyết được tàng, được dưỡng.
- Tứ khí điều thần đại luận*: mùa đông "**tảo ngọa văn khởi**", ngủ là **tàng**: thu giữ, bồi đắp tinh.

Chuỗi Đông lý: ngày dương động, đêm âm tĩnh → tối đến dương khí vào âm → thần về tàng ở tạng Tâm, huyết về Can, tinh được Thận tàng → sáng dậy dương khí ra ngoài, tinh thần

sảng khoái. Thức khuya là **hao âm, hao tinh**: đúng khái niệm "hao tổn" trong tầng Thân của lý luận (mục II).

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Mô hình hai quá trình (Borbély): áp lực ngủ tăng dần khi thức, cộng với đồng hồ sinh học ngày đêm, quyết định lúc buồn ngủ và lúc tỉnh	Dương khí hết thì ngủ; ngày đêm âm dương	C1
Khi ngủ, cơ thể tiết hormone tăng trưởng, củng cố trí nhớ, điều hoà miễn dịch, chuyển hoá; não tăng làm sạch chất thải (hệ glymphatic, chủ yếu từ nghiên cứu động vật)	Ngủ là tàng, là dưỡng	C1 (trí nhớ, hormone, miễn dịch) / C2 (glymphatic ở người)
Thiếu ngủ kéo dài liên quan béo phì, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, trầm cảm, tai nạn	Hao âm, hao tinh	C1
Thiếu ngủ làm phản ứng cảm xúc mạnh hơn, khó điều tiết	Thần không được tàng	C1

Hệ quả cho app 📱

Mọi lời khuyên trả lời một câu: **việc này giúp dương vào âm (dễ ngủ, ngủ sâu) hay giữ dương ở ngoài (khó ngủ, ngủ chập chòn)?** Tín hiệu tự cảm nhận: **dễ vào giấc, ít thức giấc giữa đêm, sáng dậy thấy đã được nghỉ, ban ngày không buồn ngủ rũ.**

A. Giấc ngủ

Cơ chế 1. Túc miên: ngủ đủ

Đông lý.

- **"Khởi cư hữu thường"** (*Thượng cổ thiên chân luận*): sinh hoạt có nề nếp.
- Ngủ đủ thì tinh khí được bồi; thiếu ngủ thì "hao" (Thủy kém thì Mộc không được nuôi: không có sức tập, theo vòng tương sinh của lý luận mục IV).
- Nhưng **"cửu ngoại thương khí"** (*Tuyên minh ngũ khí*): nằm quá lâu cũng hại khí.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Người trưởng thành (18-60 tuổi) nên ngủ ít nhất 7 giờ/đêm (khuyến nghị đồng thuận AASM và SRS, 2015); khoảng thường dùng 7-9 giờ	C1
Người cao tuổi cần khoảng 7-8 giờ; giấc ngủ nông hơn, dễ thức giấc hơn là thay đổi bình thường theo tuổi	C1
Nhu cầu ngủ khác nhau giữa các người; người ngủ ngắn bẩm sinh thật sự rất hiếm	C1-C2

Hiện tượng	Cấp
Ngủ dài thường xuyên (trên khoảng 9-10 giờ) đi kèm nguy cơ sức khoẻ, nhưng thường là dấu hiệu của bệnh (trầm cảm, suy giáp, ngưng thở khi ngủ...) chứ không phải nguyên nhân	C2
"Ngủ bù" cuối tuần chỉ bù được một phần; lệch giờ ngủ giữa ngày thường và cuối tuần ("lệch múi giờ xã hội") liên quan chuyển hoá kém hơn	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●●, Thần ●●●, Khí ●, Tâm ●.

Trong app:

- Thuộc đo chính: **thời gian ngủ ước tính** (giờ đi ngủ đến giờ dậy, trừ thời gian thức), từ check-in hoặc thiết bị.
- Mục tiêu theo tuổi: người trưởng thành **ít nhất 7 giờ**; không ép đạt con số tuyệt đối nếu người dùng thấy tỉnh táo.
- Lời khuyên với người ngủ ít: **lùi giờ đi ngủ sớm 15 phút mỗi tuần** 🕒, không đột ngột lên giường sớm hơn 1-2 tiếng (để nằm thao thức).
- Với người ngủ nhiều kéo dài kèm mệt: **không khuyên "ngủ ít lại"**, mà chạy cờ đỏ, khuyên đi khám (lý luận mục X).

Cơ chế 2. Thuận thời: giờ đều, ánh sáng đúng lúc, giấc trưa

Đông lý.

- *Tứ khí điều thần đại luận* điều chỉnh giờ ngủ theo mùa: xuân hạ **"dạ ngọa tảo khởi"** (ngủ muộn, dậy sớm), thu **"tảo ngọa tảo khởi"**, đông **"tảo ngọa văn khởi, tất đãi nhật quang"** (ngủ sớm, dậy muộn, đợi có nắng).
- Dưỡng sinh cổ truyền coi trọng **"Tý Ngọ giác"**: ngủ vào giờ Tý (23h-1h) và chợp mắt giờ Ngọ (11h-13h), hai thời điểm âm dương giao nhau [C3].
- Giờ Sửu (1h-3h) là giờ kinh Can vượng, lúc huyết về Can; thức qua giờ này là hao huyết [C3].

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Ánh sáng là tín hiệu mạnh nhất chỉnh đồng hồ sinh học: ánh sáng buổi sáng giúp ngủ sớm hơn vào tối; ánh sáng mạnh buổi tối (kể cả màn hình) làm chậm tiết melatonin, lùi giờ buồn ngủ	C1
Giờ đi ngủ và thức dậy đều đặn (kể cả cuối tuần) liên quan giấc ngủ tốt hơn và sức khoẻ chuyển hoá tốt hơn	C1-C2
Giờ thức dậy cố định là thành phần cốt lõi của điều trị mất ngủ (CBT-I)	C1
Giấc ngủ trưa ngắn (khoảng 10-30 phút) đầu giờ chiều tăng tỉnh táo; ngủ trưa dài, ngủ muộn buổi chiều có thể làm khó ngủ ban đêm	C1-C2
Ngủ trưa dài thường xuyên (trên khoảng 1 giờ) đi kèm một số nguy cơ sức khoẻ ở người lớn tuổi, nhưng có thể là dấu hiệu chứ không phải nguyên nhân	C2
Mỗi người có thiên hướng ngủ sớm hay muộn (kiểu thời sinh học) khác nhau, có phần do di truyền	C1

Hiện tượng	Cấp
Giờ Tý, giờ Sửu có ý nghĩa đặc biệt	C3

Văn hoá Việt ☞: ngủ trưa là thói quen phổ biến, nhất là ở công sở, trường học. Đây là **điểm mạnh nên giữ**, chỉ cần điều chỉnh độ dài (Tý Ngọ giấc C3 gặp giấc trưa ngắn C1-C2).

Tăng được nuôi: Thân ●●, Thần ●●, Khí ●.

Trong app:

- **Neo giờ dậy** ☞: người dùng chọn một giờ thức dậy giữ đều cả tuần (chênh không quá khoảng 1 giờ vào cuối tuần).
- **"Đón nắng sáng"** ☞: 10-30 phút ngoài trời trong 1-2 giờ đầu sau khi dậy (nối trụ Môi trường, trụ Luyện tập: đi bộ buổi sáng).
- **"Hoàng hôn trong nhà"** ☞: 1-2 giờ trước ngủ giảm đèn sáng, chuyển đèn vàng ấm, giảm màn hình.
- **Giấc trưa Việt** ☞: 15-30 phút, trước khoảng 15h; đặt báo thức.
- Lời khuyên theo mùa (C3) chỉ ở mức **điều chỉnh nhẹ** (mùa đông miền Bắc dậy muộn hơn chút khi trời còn tối), không thay đổi nguyên tắc giờ dậy đều.
- Người **làm ca đêm**: lộ trình riêng (tối buồn ngủ ban ngày, kính râm khi tan ca về, giấc ngủ chính cố định), cần chuyên gia soạn.

B. Điều kiện để ngủ

Cơ chế 3. Tâm yên thì ngủ

Đông lý.

- **Tạng Tâm tàng thần.** Đem đến thần phải về tàng thì mới ngủ; thần không yên (tâm thần bất an) thì mất ngủ.
- Dưỡng sinh cổ truyền: **"Tiên thụ tâm, hậu thụ nhĩ"**: ngủ lòng trước, ngủ mắt sau (thường dẫn từ sách dưỡng sinh đời Tống, *Thụ quyết*; cần xác định xuất xứ).
- **"Tư thương Tỳ"**: lo nghĩ hại Tỳ; Tâm Tỳ lưỡng hư là thể mất ngủ thường gặp (khó ngủ, hay mơ, hồi hộp, ăn kém) [C3].

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Trạng thái tăng kích thích (lo lắng, suy nghĩ dồn dập, cơ thể căng) trước khi ngủ là cơ chế chính duy trì mất ngủ	C1
Liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ (CBT-I) là điều trị hàng đầu cho mất ngủ mạn tính, được khuyến nghị trước thuốc ngủ (hướng dẫn của Hội Thầy thuốc Hoa Kỳ ACP 2016, Hội Nghiên cứu Giấc ngủ châu Âu 2017)	C1

Hiện tượng	Cấp
Thành phần CBT-I: kiểm soát kích thích (chỉ lên giường khi buồn ngủ, không nằm thao thức quá lâu), giờ dậy cố định , giáo dục vệ sinh giấc ngủ, xử lý suy nghĩ về giấc ngủ, thư giãn; hạn chế giấc ngủ hiệu quả nhưng cần hướng dẫn chuyên môn	C1
Thư giãn, thở chậm, thiền trước ngủ cải thiện chất lượng giấc ngủ ở mức vừa	C2
Lo lắng về chính giấc ngủ ("phải ngủ đủ 8 tiếng") làm mất ngủ nặng thêm; theo dõi giấc ngủ bằng thiết bị quá mức có thể gây lo âu ("orthosomnia")	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●●.

Trong app:

- **"Gác lại ngày hôm nay"** 🕒 5 phút, 1-2 giờ trước ngủ: ghi việc ngày mai cần làm và mối lo, để chúng "nằm trên giấy" chứ không "nằm trên gối" (nối "giờ lo lắng" của trụ Cảm xúc).
- **Bài thở và quét thân trước ngủ** (trụ Thiền, cơ chế 1, 2).
- **Quy tắc 20 phút** 🕒 (kiểm soát kích thích): nằm khoảng 20 phút mà không ngủ được thì ra khỏi giường, làm việc nhẹ nhàng dưới ánh đèn mờ, buồn ngủ mới quay lại. Không nhìn đồng hồ liên tục.
- **Giường chỉ để ngủ** 🕒: không làm việc, không lướt điện thoại trên giường.
- **Không tự triển khai "hạn chế giấc ngủ"** trong phiên bản đầu (cần chuyên gia; chống chỉ định ở một số người như động kinh, rối loạn lưỡng cực, người lái xe nghề).

Cơ chế 4. Vị hoà thì ngủ

Đông lý. *Tố Vấn, "Nghịch điều luận": "Vị bất hoà tắc ngọa bất an":* dạ dày không yên thì nằm không yên. Rượu tính nhiệt, sinh thấp nhiệt, làm thần không yên [C3].

Tây chứng. Đã trình bày ở *Cơ chế trụ Ăn uống* (cơ chế 5, 6, 7). Tóm tắt:

Yếu tố	Tác động lên giấc ngủ	Cấp
Ăn no sát giờ ngủ	Tăng trào ngược, khó ngủ	C1
Caffeine muộn	Uống 6 giờ trước khi ngủ vẫn giảm giấc ngủ; bán thải trung bình khoảng 5 giờ	C1
Rượu	Dễ vào giấc nhưng vỡ giấc nửa đêm sau, giảm giấc REM	C1
Uống nhiều nước buổi tối	Thức dậy đi tiểu đêm	C1-C2
Nicotine	Chất kích thích, làm khó ngủ	C1

Tăng được nuôi: Thân ●, Thần ●●.

Trong app:

- Khi điếm ngủ thấp, app **hỏi ba hướng trước khi khuyên** (lý luận mục IV.3): bữa tối, cà phê, rượu (Vị bất hoà) → màn hình, ánh sáng (cửu thị) → lo nghĩ (tâm động).

- Gợi ý cụ thể lấy từ trụ Ăn uống: ăn xong trước giờ ngủ 2–3 giờ; ly cà phê cuối trước khoảng 14h (tùy giờ ngủ); không dùng rượu để dễ ngủ.

Cơ chế 5. Chỗ ngủ yên

Đông lý.

- **"Cửu thị thương huyết"**: nhìn lâu hại huyết; mà đêm là lúc huyết về Can. Nhìn màn hình khuya là hao huyết hai lần ☹.
- Dưỡng sinh cổ truyền: chỗ ngủ tránh gió lùa (phong là đầu của lục dâm), không nằm chỗ ẩm thấp, đầu mát chân ấm [C3].

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Phòng ngủ tối, yên tĩnh, mát hỗ trợ giấc ngủ; nhiệt độ phòng quá nóng làm giấc ngủ chập chờn	C1–C2
Tiếng ồn ban đêm (giao thông, hàng xóm) làm vỡ giấc ngủ, liên quan tăng nguy cơ tim mạch (hướng dẫn tiếng ồn của WHO 2018)	C1–C2
Dùng thiết bị điện tử trên giường, nhất là nội dung kích thích, làm muộn giờ ngủ và giảm thời gian ngủ	C2
Ánh sáng trong phòng khi ngủ (đèn, tivi để mở) liên quan chuyển hoá kém hơn trong một số nghiên cứu	C2
Đầu mát chân ấm; hướng giường	C2 (làm ấm bàn chân giúp vào giấc nhanh hơn) / C3 (hướng giường, phong thủy)

Văn hoá và hoàn cảnh Việt ☹:

- Khí hậu nóng ẩm: điều hoà, quạt, màn chống muỗi là điều kiện ngủ thực tế. Nên khuyến nhiệt độ dễ chịu, **tránh để quạt hay điều hoà thổi thẳng vào người** (gặp "tránh gió lùa" C3 và tránh khô họng, lạnh cục bộ).
- Nhà phố gần đường, karaoke, nhà ở nhiều thế hệ, ngủ chung với con: lời khuyên phải **khả thi** (nút tai, rèm dày, quạt tạo tiếng đều), không đòi hỏi "phòng ngủ riêng hoàn hảo".

Tăng được nuôi: Thân ●, Thần ●●.

Trong app:

- **"Kiểm tra chỗ ngủ"** ☹ một lần: tối · yên · mát · không màn hình · thoải mái. Gợi ý cải thiện từng mục với chi phí thấp.
- Chế độ **"Đi ngủ"**: nhắc bật chế độ không làm phiền, để điện thoại xa giường (nối trụ Môi trường, cơ chế ánh sáng và màn hình).

C. Nghỉ

Cơ chế 6. Bất vọng tác lao: nghỉ giữa giờ, ngày nghỉ, hồi phục

Đông lý.

- *Thượng cổ thiên chân luận*: "**Bất vọng tác lao**": không lao lực cần.
- "**Lao tắc khí hao**" (*Cử thống luận*): lao lực thì khí hao.
- **Điều hoà âm dương** (pháp tắc 1): động và tĩnh, làm và nghỉ đan xen. "Ngủ nghỉ" không chỉ là ngủ đêm, mà là mọi khoảng **tĩnh** cân bằng cho **động**.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Làm việc từ 55 giờ/tuần trở lên liên quan tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim thiếu máu cục bộ (ước tính của WHO và ILO, 2021)	C1
Nghỉ ngắn trong giờ làm việc giảm mệt mỏi, tăng sức tập trung	C2
Tách rời tâm lý khỏi công việc ngoài giờ (không nghĩ, không trả lời việc) liên quan hồi phục tốt hơn và ít kiệt sức hơn	C2
Kỳ nghỉ cải thiện sức khoẻ tinh thần, nhưng tác dụng phai nhanh sau khi quay lại làm việc	C2
Kiệt sức nghề nghiệp (burnout) được WHO mô tả là hiện tượng nghề nghiệp do căng thẳng công việc kéo dài không được quản lý tốt	C1 (về định nghĩa)

Tầng được nuôi: Khí ●●, Tâm ●●, Thân ●.

Trong app:

- "**Nghỉ năm phút**" 🕒 sau mỗi khoảng 60-90 phút làm việc tập trung: rời màn hình, nhìn xa, đứng dậy, thở (gộp với nhắc của trụ Luyện tập và Thiền thành **một** lời nhắc, tránh làm phiền).
- "**Ranh giới tối**" 🕒: một giờ cố định không xem việc, không email công việc (người dùng tự chọn).
- "**Một ngày tĩnh**" 🕒 mỗi tuần: ngày có ít nhất một khoảng dài không công việc, không mục tiêu (gặp "ngày nghỉ" của trụ Luyện tập).
- Theo dõi **chỉ báo hao tổn** của tầng Thân (lý luận mục II): số đêm thức khuya, số ngày làm việc quá sức trong tuần. Nhiều tuần liên tiếp cao thì nhắc "lao tắc khí hao".

Tổng hợp: trụ Ngủ nghỉ nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
0. Âm dương giao (nền)	●●●	●	●	●●●	(khung giải thích)
1. Túc miên	●●●	●	●	●●●	Ngủ ít nhất 7 giờ

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
2. Thuận thời	●●	●		●●	Giờ dậy đều; nắng sáng; tối giảm sáng; ngủ trưa ngắn
3. Tâm yên thì ngủ			●●	●●●	CBT-I: kiểm soát kích thích, giờ dậy cố định
4. Vị hoà thì ngủ	●			●●	Bữa tối sớm, cà phê sớm, không rượu
5. Chỗ ngủ yên	●			●●	Tối, yên, mát; màn hình xa giường
6. Bất vọng tác lao	●	●●	●●		Nghỉ giữa giờ; không làm việc quá sức

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Ngủ nghỉ: Thân ●●●, Khí ●, Tâm ●, Thần ●●●). Đề xuất xem xét nâng **Khí lên ●●** nhờ cơ chế 6 (nghỉ ngơi hồi phục khí).

Ngủ nghỉ tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Ngủ nghỉ → Luyện tập	Thủy sinh Mộc: ngủ đủ thì có sức tập, hồi phục tốt	C1
Luyện tập → Ngủ nghỉ	Vận động đều đặn cải thiện giấc ngủ; tránh gắng sức nặng sát giờ ngủ	C1-C2
Ngủ nghỉ → Ăn uống	Thiếu ngủ tăng đói, thèm đồ ngọt béo	C1-C2
Ăn uống → Ngủ nghỉ	Vị bất hoà tắc ngọ bất an; cà phê, rượu, bữa khuya	C1
Thiền → Ngủ nghỉ	Kim sinh Thủy: thở chậm, tĩnh tâm thì dễ ngủ	C2
Ngủ nghỉ ↔ Cảm xúc	Tâm yên thì ngủ; thiếu ngủ làm cảm xúc dễ bùng nổ; mất ngủ là yếu tố nguy cơ trầm cảm	C1
Môi trường → Ngủ nghỉ	Ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, công việc ca đêm	C1-C2

Đo lường trụ Ngủ nghỉ 🛏

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Check-in buổi sáng (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Tối qua bạn đi ngủ lúc mấy giờ, sáng dậy lúc mấy giờ?	Giờ (hoặc lấy từ thiết bị)	1, 2
2	Bạn mất bao lâu để ngủ được?	<15 phút · 15-30 · 30-60 · >60	3
3	Đêm qua bạn thức giấc nhiều không?	Không · 1-2 lần · Nhiều lần	3, 4, 5
4	Sáng nay bạn thấy đã được nghỉ đến đâu?	0-10	Nền

Giờ ăn tối, ly cà phê cuối, rượu bia lấy từ check-in trụ Ăn uống (không hỏi lại).

Tự động (nếu người dùng cho phép)

- Thời lượng ngủ từ đồng hồ, điện thoại: **dùng làm tham khảo**. Thiết bị đeo đo **thời lượng** khá tốt nhưng đo **các giai đoạn ngủ** kém chính xác; app **không hiển thị "điểm giấc ngủ sâu"** như kết luận.

Hàng tuần

- Độ đều giờ dậy** (chênh lệch giữa các ngày).
- Chỉ báo hao tổn**: số đêm ngủ sau 0h, số ngày làm việc quá sức.

Định kỳ (cần chuyên gia chọn công cụ đã thẩm định tiếng Việt)

- Chỉ số mức độ mất ngủ** (ISI) mỗi 4 tuần nếu người dùng ngủ kém.
- Thang buồn ngủ Epworth** (ESS) khi có than phiền buồn ngủ ban ngày.
- STOP-Bang** (sàng lọc ngưng thở khi ngủ) khi có ngáy to, mệt dù ngủ đủ.

Không đo

- Không xếp hạng giấc ngủ, không so sánh với người khác.
- Không gửi thông báo báo động về một đêm ngủ kém. Chỉ nói về **xu hướng** (lý luận mục X: bảo vệ người hay lo âu).

An toàn riêng cho trụ Ngủ nghỉ

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần bác sĩ duyệt**.

Cờ đỏ khẩn cấp

Dấu hiệu	Hành động
Buồn ngủ đến mức ngủ gật khi lái xe	Khuyến không lái xe khi buồn ngủ; dừng xe nghỉ ngay; đi khám
Ý nghĩ tự hại (thường đi kèm mất ngủ nặng, trầm cảm)	Theo mục X của lý luận: số 115 và đường dây hỗ trợ đã xác minh

Cờ đỏ cần đi khám

Dấu hiệu	Hành động
Ngáy to, người ngủ cùng thấy ngưng thở, thức dậy thở hổn hển, buồn ngủ ban ngày, tăng huyết áp khó kiểm soát	Nghi ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn : khuyến đi khám (bệnh phổ biến, điều trị hiệu quả, nếu bỏ qua tăng nguy cơ tim mạch, tai nạn)
Mất ngủ ≥ 3 đêm/tuần kéo dài ≥ 3 tháng, ảnh hưởng ban ngày	Mất ngủ mạn tính: khuyến đi khám; giới thiệu CBT-I

Dấu hiệu	Hành động
Ngủ nhiều, mệt mỏi kéo dài không rõ lý do	Khuyến đi khám (thiếu máu, tuyến giáp, trầm cảm...)
Khó chịu, bứt rứt ở chân buổi tối, phải cử động mới đỡ	Nghi hội chứng chân không yên: khuyến đi khám
Ngủ gật đột ngột ban ngày, yếu cơ khi cười hoặc xúc động	Khuyến đi khám chuyên khoa
Hành vi bất thường khi ngủ: la hét, đánh đấm theo giấc mơ, mộng du gây nguy hiểm	Khuyến đi khám

Thuốc ngủ và thực phẩm chức năng

- App **không** gợi ý **thuốc ngủ**, không gợi ý **melatonin** hay sản phẩm hỗ trợ ngủ. Melatonin ở một số nơi được bán như thực phẩm chức năng nhưng không phải lựa chọn hàng đầu cho mất ngủ mạn tính và có thể tương tác thuốc; cần hỏi bác sĩ.
- Người đang dùng thuốc ngủ: nhắc **không tự ý ngưng đột ngột** (có thể gây mất ngủ dội ngược, một số thuốc gây triệu chứng cai), trao đổi với bác sĩ.
- Không gợi ý **rượu thuốc, rượu ngâm để dễ ngủ**.

Khoá và điều chỉnh

Tình trạng	Điều chỉnh
Làm ca đêm, ca xoay	Lộ trình riêng; không áp "giờ dậy đều" chuẩn
Thai kỳ	Gợi ý tư thế nằm nghiêng (theo bác sĩ sản); ngứa mới xuất hiện, phù, đau đầu thì khám
Có con nhỏ, chăm người bệnh	Không đặt mục tiêu "7 giờ liên tục"; gợi ý ngủ bù khi có thể, chia sẻ việc chăm sóc
Rối loạn lưỡng cực, động kinh	Không gợi ý thức khuya, hạn chế giấc ngủ; giấc ngủ đều đặn đặc biệt quan trọng

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🍷

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Thuận thời	Chọn một giờ dậy cố định, giữ cả tuần
2	Thuận thời	Đón nắng sáng 10-20 phút
3	Vị hoà	Ly cà phê cuối trước 14h; ăn tối xong trước giờ ngủ 3 tiếng
4	Chỗ ngủ	"Hoàng hôn trong nhà"; điện thoại xa giường
5	Tâm yên	"Gác lại ngày hôm nay" và bài thở trước ngủ
6	Tâm yên	Quy tắc 20 phút nếu nằm không ngủ được
7-12	Túc miên, nghỉ	Lùi giờ ngủ sớm dần đến đủ 7 giờ; ranh giới tối; ngày tĩnh mỗi tuần

Hai lối vào theo bốn tầng:

- Người **mệt mỏi, suy nhược** (Thân yếu): Ngủ nghỉ là cửa vào đầu tiên; bắt đầu từ cơ chế 1, 2.
- Người **căng thẳng, khó ngủ vì lo nghĩ** (Tâm, Thần yếu): bắt đầu từ cơ chế 3 kết hợp trệ Thiên và trệ Cảm xúc.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

- Đối chiếu nguyên văn: *Linh Khu "Khẩu vấn", "Doanh vệ sinh hội", "Đại hoặc luận", Ngũ tạng sinh thành, Nghịch điều luận, Cử thống luận, Tứ khí điều thần đại luận*; xuất xứ "Tý Ngọ giác", "tiên thụ tâm, hậu thụ nhãn".
- Các thể mất ngủ cổ truyền dùng làm khung giải thích (không chẩn đoán).
- Điều chỉnh giờ ngủ theo mùa cho miền Bắc, miền Nam.

Bác sĩ chuyên về giấc ngủ, chuyên gia tâm lý:

- Nội dung các bài theo CBT-I có thể đưa vào app an toàn; ranh giới với điều trị.
- Bộ cờ đồ (ngưng thở khi ngủ, chân không yên, ngủ rũ, hành vi khi ngủ).
- Công cụ ISI, ESS, STOP-Bang bản tiếng Việt đã thẩm định.
- Lộ trình cho người làm ca đêm, người có con nhỏ.
- Chính sách về thuốc ngủ, melatonin, thực phẩm chức năng.
- Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.

Trụ Môi trường sống

Hành chủ đạo: Bao trùm

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một hoàn cảnh hoặc việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Động lý, Tây chứng, tầng được nuôi, trong app**.

Trụ Môi trường khác năm trụ kia: nó **bao trùm**. Năm trụ còn lại là **việc mình làm**; Môi trường là **nơi mình sống và những người mình sống cùng**. Vì vậy trụ này có hai vai:

- Một trụ dưỡng**: những việc người dùng tự làm được (mở cửa sổ, ra công viên, gọi điện cho bạn).
- Bộ điều chỉnh của năm trụ còn lại**: thời tiết, không khí, hoàn cảnh sống **đổi lời khuyên** của các trụ khác (lý luận mục V: Môi trường **đổi mục tiêu và lời khuyên, không trừ điểm**).

Trụ Môi trường có **một cơ chế nền và bảy cơ chế**, chia hai nhóm theo định nghĩa của lý luận (mục III): **tự nhiên** (thiên, địa) và **xã hội** (nhân).

Nhóm	Cơ chế
A. Tự nhiên (thiên, địa)	1. Thuận khí hậu: nóng, lạnh, ẩm theo mùa và miền · 2. Thanh khí: không khí trong và ngoài nhà · 3. Ánh sáng và màn hình · 4. Tĩnh âm: tiếng ồn · 5. Gần thiên nhiên và nơi ở lành
B. Xã hội (nhân)	6. Nhân hoà: gia đình, bạn bè, cộng đồng · 7. Nhịp sống: công việc và đời sống số

Nền chung là **cơ chế gốc: thiên - địa - nhân hợp nhất**.

Hành chủ đạo: bao trùm (không gán một hành). **Tạng cùng tham gia**: toàn thân.

Lập trường 🍵

- Công bằng và khả thi**. Nhiều người không chọn được nơi ở, công việc, không khí mình thở. Lời khuyên phải **làm được với hoàn cảnh thật**, không đổ lỗi cho người dùng vì những điều nằm ngoài tầm tay.
- Không phong thủy**. Lục Dưỡng không đưa lời khuyên về hướng nhà, vật phẩm, màu hợp mệnh. Những điều đó ngoài phạm vi dưỡng sinh có kiểm chứng.
- Riêng tư**. Vị trí, quan hệ gia đình là dữ liệu nhạy cảm; chỉ thu khi người dùng đồng ý và khi thật sự cần.

Cơ chế gốc: thiên - địa - nhân hợp nhất

Đông lý

- *Tổ Vấn, "Bảo mệnh toàn hình luận"*: "**Nhân dĩ thiên địa chi khí sinh, tứ thời chi pháp thành**": người sinh ra nhờ khí trời đất, thành hình theo phép bốn mùa.
- *Linh Khu, "Bản thân"*: người trí dưỡng sinh "**thuận tứ thời nhi thích hàn thử, hoà hỷ nộ nhi an cư xứ**": thuận bốn mùa mà thích nghi nóng lạnh, điều hoà vui giận mà yên chỗ ở.
- **Lục dâm** (phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả) là **ngoại nhân**: khí hậu thái quá hoặc trái mùa xâm phạm cơ thể. Lục Dưỡng mở rộng thêm **ô nhiễm, tiếng ồn, ánh sáng nhân tạo** 📢 (lý luận mục VI).
- *Tổ Vấn, "Dị pháp phương nghi luận"*: người năm phương (đông, tây, nam, bắc, trung ương) sống ở khí hậu khác nhau, ăn ở khác nhau, nên bệnh khác nhau, phép chữa khác nhau: nền của "**nhân địa chế nghi**".
- **Chính khí tôn nội, tà bất khả can** (*Tổ Vấn, "Thích pháp luận"*, thiên bổ di; cần đối chiếu): chính khí đủ thì tà khí không xâm phạm được. Năm trụ kia nuôi chính khí; trụ Môi trường **giảm tà khí**.

Chuỗi Đông lý: con người sống giữa trời (khí hậu, ánh sáng), đất (nơi ở, không khí, nước) và người (gia đình, cộng đồng) → hài hoà thì chính khí được nuôi → trái nghịch, thái quá thì tà khí xâm phạm (ngoại nhân) hoặc cảm xúc tổn thương (nội nhân) → mất quân bình.

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Môi trường (ô nhiễm không khí, nhiệt độ cực đoan, nước, hoá chất) là nguyên nhân của một phần lớn gánh nặng bệnh tật toàn cầu (WHO)	Ngoại nhân: lục dâm	C1
Các yếu tố xã hội quyết định sức khoẻ (nơi ở, việc làm, thu nhập, quan hệ xã hội) ảnh hưởng sức khoẻ mạnh không kém hành vi cá nhân	Thiên - địa - nhân	C1
Kết nối xã hội ảnh hưởng tuổi thọ và sức khoẻ tinh thần	Hài hoà với con người	C1

Hệ quả cho app 📢

Mọi lời khuyên trả lời hai câu: **có giảm được tà khí trong tầm tay không?** và **có làm mối quan hệ với trời, đất, người hài hoà hơn không?** Tín hiệu tự cảm nhận: **nhà ở dễ chịu, thở thoáng, có lúc được ra ngoài trời, có người để gặp và chia sẻ, nhịp làm việc không nuốt hết cuộc sống**.

A. Tự nhiên (thiên, địa)

Cơ chế 1. Thuận khí hậu: nóng, lạnh, ẩm theo mùa và miền

Đông lý.

- Tứ khí điều thân đại luận: sống thuận bốn mùa (xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng).
- Ba tà khí đáng chú ý nhất ở Việt Nam ☞:
 - Thử** (nắng nóng mùa hè): hao khí, tổn tân dịch.
 - Thấp** (ẩm): miền Bắc mùa **nồm** cuối đông đầu xuân, miền Nam mùa mưa; thấp làm Tỳ bị khốn, nặng nề, đau mỏi.
 - Hàn** (rét): miền Bắc và vùng núi phía Bắc mùa đông.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Nắng nóng cực đoan làm tăng tử vong, nhập viện (sốc nhiệt, bệnh tim mạch, thận); người cao tuổi, trẻ nhỏ, người bệnh mạn tính, người lao động ngoài trời có nguy cơ cao	C1
Rét đậm làm tăng biến cố tim mạch, đột quy, bệnh hô hấp, nhất là ở người cao tuổi	C1
Độ ẩm cao trong nhà thúc đẩy nấm mốc, mạt bụi, liên quan hen, viêm mũi dị ứng	C1-C2
Biến đổi khí hậu làm tăng tần suất nắng nóng, thời tiết cực đoan ở Việt Nam	C1
Thấp làm Tỳ khốn	C3

Tăng được nuôi: Thân ●●, Khí ●.

Trong app:

- Kết nối **thời tiết theo vị trí** (nếu người dùng cho phép), có **cảnh báo theo ngưỡng** do chuyên gia chốt:
 - Nắng nóng:** nhắc uống nước, tránh ra ngoài 10h-16h, tập trong nhà (đổi gọi ý trụ Luyện tập), quan tâm người già trong nhà.
 - Rét đậm:** giữ ấm đầu, cổ, ngực, bàn chân; người tăng huyết áp, bệnh tim không ra ngoài quá sớm; không sưởi than trong phòng kín (xem cờ đỏ).
 - Nồm ẩm:** đóng cửa khi trời nồm, dùng máy hút ẩm hoặc điều hoà chế độ khô, phơi sấy chăn màn khi có nắng.
- Lời khuyên theo **tiết khí** (C3) có **bộ điều chỉnh cho miền Nam** (lý luận mục V).

Cơ chế 2. Thanh khí: không khí trong và ngoài nhà

Đông lý.

- Phế chủ khí, khai khiếu ra mũi**, là "kiểu tạng" (tạng mềm yếu), dễ bị tà khí từ ngoài xâm phạm qua đường thở.

- Khí trời hít vào cùng cốc khí tạo **tông khí** (trụ Luyện tập, cơ chế 2): khí trời không trong thì tông khí không thuần ☹.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Bụi mịn PM2.5 làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi, ung thư phổi, tử vong sớm. WHO (hướng dẫn chất lượng không khí 2021) khuyến nghị trung bình năm không quá 5 µg/m³	C1
Hà Nội, TP.HCM và nhiều đô thị Việt Nam thường xuyên vượt ngưỡng WHO, có những đợt ô nhiễm nặng (cần số liệu mới nhất)	C1
Ô nhiễm trong nhà : đun nấu bằng than, củi, bếp than tổ ong ; khói thuốc lá thụ động; đốt hương, nhang trong phòng kín tạo bụi mịn và chất độc hại	C1 (than, củi, thuốc lá) / C1-C2 (hương)
Thông gió, máy lọc không khí có màng lọc HEPA giảm bụi mịn trong nhà	C1 (giảm bụi) / C2 (lợi ích sức khoẻ trực tiếp)
Khẩu trang đạt chuẩn lọc (như N95, KN95) đeo kín giảm hít bụi mịn; khẩu trang vải, y tế thông thường lọc kém hơn	C1-C2

Lưu ý văn hoá ☹: thắp hương là nét đẹp tâm linh của người Việt. Lục Dưỡng **không khuyên bỏ**, chỉ gợi ý **giảm phơi nhiễm**: mở cửa thông gió khi thắp, thắp ít nén, không ngồi lâu cạnh khói, chọn hương ít khói hoặc hương không tẩm hoá chất (cần chuyên gia xác nhận).

Tầng được nuôi: Thân ●●, Khí ●●.

Trong app:

- Kết nối **chỉ số chất lượng không khí (AQI)** theo vị trí. Khi AQI xấu: đổi gợi ý tập ngoài trời sang trong nhà (trụ Luyện tập), nhắc đóng cửa sổ, bật lọc không khí nếu có, đeo khẩu trang đạt chuẩn khi ra đường.
- **"Kiểm tra không khí trong nhà"** ☹ một lần: có hút thuốc trong nhà không, đun bếp gì, có thông gió bếp không, thắp hương ở phòng nào, có nấm mốc không. Gợi ý cải thiện theo từng mục, ưu tiên việc rẻ và dễ.
- Hằng ngày: **mở cửa thông gió** khi không khí ngoài trời tốt (AQI tốt, không nồm).

Cơ chế 3. Ánh sáng và màn hình

Đông lý.

- **Ngày dương, đêm âm.** Sống thuận ánh sáng tự nhiên là thuận âm dương. *Tứ khí điều thần*: mùa đông **"tất đãi nhật quang"**: đợi có ánh nắng.
- **"Cửu thị thương huyết"** (*Tuyên minh ngũ khí*): nhìn lâu hại huyết. Màn hình là "cửu thị" của thời hiện đại ☹.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Ánh sáng ban ngày, nhất là buổi sáng, chỉnh đồng hồ sinh học, cải thiện giấc ngủ, tỉnh táo, tâm trạng	C1
Ánh sáng mạnh, màn hình buổi tối làm chậm melatonin, lùi giờ ngủ	C1-C2
Nhìn màn hình gần liên tục gây mỏi mắt, khô mắt; nghỉ nhìn xa định kỳ giảm triệu chứng	C1 (mỏi mắt)
Thời gian ở ngoài trời nhiều hơn giảm nguy cơ cận thị ở trẻ em	C1 (ở trẻ em; ngoài phạm vi phiên bản đầu)
Ánh nắng giúp cơ thể tạo vitamin D; cân cân bằng với nguy cơ tia UV	C1

Tăng được nuôi: Thân ●, Thần ●●.

Trong app:

- **"Đón nắng sáng"** (chung với trụ Ngủ nghỉ, cơ chế 2).
- **Quy tắc 20-20-20** 📖: mỗi 20 phút nhìn màn hình, nhìn xa khoảng 6 mét (20 feet) trong 20 giây. Gộp vào lời nhắc nghỉ chung của trụ Ngủ nghỉ, cơ chế 6.
- **Thời gian màn hình buổi tối** (nếu điện thoại cho phép đọc): chỉ hiển thị xu hướng, gợi ý "hoàng hôn trong nhà".
- **Nắng gắt (UV cao):** nhắc che chắn, kem chống nắng (nói cơ chế 1).

Cơ chế 4. Tĩnh âm: tiếng ồn

Đông lý.

- **"Tĩnh tắc thần tàng, táo tắc tiêu vong"** (Tổ VẤN, "Tý luận"): tĩnh thì thần được tàng, xao động thì hao mất. Tiếng ồn là một dạng "táo" từ bên ngoài 📖.
- **Thận khai khiếu ra tai;** tai bị tổn thương lâu ngày gắn với Thận hư theo cổ truyền [C3].

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Tiếng ồn giao thông kéo dài liên quan rối loạn giấc ngủ, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ (hướng dẫn tiếng ồn môi trường của WHO khu vực châu Âu, 2018)	C1-C2
Tiếng ồn ban đêm làm vỡ giấc ngủ dù người ngủ không tỉnh hẳn	C1
Tiếp xúc âm thanh lớn kéo dài (nơi làm việc, tai nghe to, karaoke) gây suy giảm thính lực không hồi phục	C1
Tiếng ồn làm giảm khả năng tập trung, tăng khó chịu, căng thẳng	C2

Hoàn cảnh Việt 📖: xe máy, còi xe, công trình, karaoke, loa phường. Phần lớn ngoài tầm kiểm soát của cá nhân, nên lời khuyên tập trung vào **giảm phơi nhiễm** và **bảo vệ tai**.

Tăng được nuôi: Tâm ●, Thần ●●, Thân ● (thính lực, huyết áp).

Trong app:

- Gợi ý **góc yên tĩnh** 📍 trong nhà cho thiền, ngủ: rèm dày, nút tai khi ngủ, quạt hoặc máy tạo tiếng đều để che tiếng ồn.
- Bảo vệ tai**: tai nghe không quá khoảng 60% âm lượng, không đeo liên tục quá lâu; nghe nhiều tiếng ồn thì dùng bảo hộ (cần chuyên gia chốt ngưỡng).
- "Muời phút tĩnh"** 📍: mỗi ngày một khoảng không nhạc, không video, không tiếng nền (nối trụ Thiền).

Cơ chế 5. Gần thiên nhiên và nơi ở lành

Đông lý.

- Thiên nhân hợp nhất: con người là một phần của tự nhiên, xa tự nhiên thì mất nhịp.
- Linh Khu*, "*Bản thân*": **"an cư xứ"**: yên chỗ ở. Nơi ở là gốc của sinh hoạt hằng ngày.
- Văn hoá Việt: nhà có vườn, ao, cây; **"Nhất cận thị, nhị cận giang"** (gần chợ, gần sông) là lựa chọn nơi ở thuận đời sống. Tuệ Tĩnh trồng thuốc Nam quanh nơi ở 📍.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Sống gần không gian xanh liên quan sức khoẻ tinh thần tốt hơn, vận động nhiều hơn, tử vong thấp hơn (nghiên cứu quan sát, khó loại nhiễu như thu nhập)	C2
Đi bộ, ở trong thiên nhiên (kể cả "tắm rừng" kiểu Nhật Bản) giảm căng thẳng tự báo cáo, cải thiện tâm trạng ngắn hạn	C2
Khoảng 120 phút/tuần tiếp xúc thiên nhiên liên quan sức khoẻ và hạnh phúc tốt hơn (White và cộng sự 2019, nghiên cứu quan sát ở Anh)	C2
Nhà ẩm mốc, chật chội, nóng bức, thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh liên quan nhiều bệnh hô hấp, nhiễm trùng	C1
Cây xanh trong nhà lọc không khí đáng kể	C3 (hiệu quả lọc rất nhỏ ở mức nhà ở thật; có thể có lợi về tâm lý)

Tầng được nuôi: Tâm ●●, Khí ●, Thần ●.

Trong app:

- "Hai giờ thiên nhiên mỗi tuần"** 📍: cộng dồn thời gian ở công viên, bờ hồ, vườn, ruộng, biển, núi. Gộp với đi bộ (trụ Luyện tập) và thiền đi (trụ Thiền).
- Gợi ý **thiên nhiên trong tầm tay** cho người ở chung cư, nhà phố: ban công vài chậu cây, trồng rau thơm, ngồi gần cửa sổ, công viên gần nhất.
- "Kiểm tra nhà ở"** 📍 (gộp với kiểm tra không khí và chỗ ngủ): ẩm mốc, thông gió, nước sạch, bếp, nhà vệ sinh, an toàn chống ngã (người cao tuổi: thảm, tay vịn, đèn đêm).

B. Xã hội (nhân)

Cơ chế 6. Nhân hoà: gia đình, bạn bè, cộng đồng

Đông lý.

- Định nghĩa sức khoẻ của Lục Dưỡng: hài hoà với **trời, đất và con người** (lý luận mục III).
- Văn hoá Việt: "**Thiên thời, địa lợi, nhân hoà**"; "**Bán anh em xa, mua láng giềng gần**"; bữa cơm gia đình là trung tâm đời sống.
- Thất tình (nội nhân) phần lớn khởi từ **quan hệ với người**; quan hệ hài hoà là tuyến phòng giữ nội nhân (lý luận mục VI) 🍵.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Kết nối xã hội mạnh liên quan giảm nguy cơ tử vong; cô lập xã hội và cô đơn tăng nguy cơ, mức tác động được so sánh với các yếu tố nguy cơ lối sống quen thuộc (Holt-Lunstad và cộng sự 2010, 2015)	C1
WHO đã lập Ủy ban về Kết nối xã hội (từ 2023), coi cô đơn và cô lập xã hội là vấn đề sức khoẻ cộng đồng	C1
Cô đơn liên quan trầm cảm, bệnh tim mạch, đột quỵ, sa sút trí tuệ	C1-C2
Quan hệ có xung đột kéo dài (hôn nhân, gia đình, nơi làm việc) gây hại sức khoẻ; chất lượng quan hệ quan trọng không kém số lượng	C1-C2
Làm tình nguyện, giúp đỡ người khác liên quan sức khoẻ tinh thần tốt hơn	C2
Ăn cùng người khác liên quan chế độ ăn tốt hơn, tâm trạng tốt hơn	C2

Hoàn cảnh Việt 🍵:

- Gia đình nhiều thế hệ**: vừa là nguồn nâng đỡ lớn, vừa có thể là nguồn áp lực (kỳ vọng, can thiệp, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu).
- Di cư lên đô thị, đi làm xa**: nhiều người trẻ sống một mình, xa gia đình; nhiều người già ở quê sống thiếu con cháu.
- Văn hoá nhậu, tiếp khách**: kết nối gắn với rượu bia (nổi trự Ăn uống, cơ chế 7).

Phân công với trự Cảm xúc: trự Môi trường lo **mạng lưới** (có ai, gặp bao nhiêu, tham gia cộng đồng nào). Trự Cảm xúc lo **chất lượng chia sẻ cảm xúc** (có dám nói ra, có được lắng nghe).

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●, Khí ●.

Trong app:

- "**Bữa cơm cùng nhau**" 🍵: ít nhất vài bữa mỗi tuần ăn cùng gia đình hoặc bạn bè, cắt điện thoại (nổi trự Ăn uống và Thiền).

- **"Một lời hỏi thăm"** ☞ mỗi tuần: gọi điện, nhắn tin hỏi thăm một người (cha mẹ ở quê, bạn cũ, hàng xóm lớn tuổi).
- **Gợi ý cộng đồng** ☞: câu lạc bộ dưỡng sinh, đi bộ, dân vũ, cầu lông, nhóm tình nguyện, sinh hoạt tôn giáo nếu người dùng có tín ngưỡng.
- **Kết nối không gắn với rượu** ☞: gợi ý hoạt động thay thế (cà phê sáng, đi bộ, thể thao) khi người dùng đang giảm rượu bia.
- Không xây mạng xã hội công khai trong phiên bản đầu.

Cơ chế 7. Nhịp sống: công việc và đời sống số

Đông lý.

- **"Bất vọng tác lao", "lao tác khí hao"**: lao lực thì khí hao.
- **Khởi cư hữu thường**: sinh hoạt có nề nếp. Công việc và thiết bị số quyết định phần lớn nhịp sinh hoạt của người hiện đại ☞.
- **"Cửu toạ thương nhục, cửu thị thương huyết"**: công việc văn phòng là hai trong năm mẫu ngũ lao.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Làm việc từ 55 giờ/tuần trở lên liên quan tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim (WHO và ILO, 2021)	C1
Căng thẳng công việc (yêu cầu cao, ít quyền tự chủ, mất cân bằng nỗ lực – phần thưởng) liên quan bệnh tim mạch, trầm cảm	C1-C2
Làm ca đêm kéo dài liên quan rối loạn chuyển hoá, giấc ngủ; IARC xếp làm ca đêm là "có thể gây ung thư" (nhóm 2A)	C1-C2
Mạng xã hội: tác động lên sức khoẻ tinh thần không đồng nhất ; dùng thụ động, so sánh, dùng khuya liên quan tâm trạng kém hơn; dùng để kết nối thật có thể có lợi	C2
Thông báo liên tục, đa nhiệm làm giảm tập trung và tăng căng thẳng	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●, Khí ●.

Trong app:

- Chỉ báo **giờ làm việc trong tuần** (tùy chọn, người dùng tự nhập): vượt ngưỡng nhiều tuần thì nhắc "lao tác khí hao", gợi ý ranh giới (nối trụ Ngủ nghỉ, cơ chế 6).
- **"Thói quen số lành"** ☞: tắt thông báo không cần thiết, gom thời gian xem mạng xã hội, không lướt điện thoại trên giường, một buổi mỗi tuần "không màn hình".
- **Bản thân app Lục Dưỡng cũng tuân thủ**: gộp lời nhắc, tôn trọng giờ ngủ, không dùng kỹ thuật gây nghiện (cuộn vô tận, phần thưởng ngẫu nhiên, thông báo dồn dập).
- Người làm ca đêm, lao động ngoài trời, công nhân: lộ trình riêng, khả thi với điều kiện làm việc.

Tổng hợp: trụ Môi trường nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực
0. Thiên - địa - nhân (nền)	●	●●	●●	●	(khung giải thích)
1. Thuận khí hậu	●●	●			Phòng nắng nóng, rét đậm, nồm ẩm [C1]
2. Thanh khí	●●	●●			Giảm bụi mịn, khói trong nhà; theo dõi AQI [C1]
3. Ánh sáng, màn hình	●			●●	Năng sáng; giảm màn hình tối [C1-C2]
4. Tĩnh âm	●		●	●●	Giảm tiếng ồn khi ngủ; bảo vệ tai [C1-C2]
5. Thiên nhiên, nơi ở		●	●●	●	120 phút thiên nhiên/tuần [C2]; nhà khô thoáng [C1]
6. Nhân hoà		●	●●	●●	Duy trì kết nối; bữa cơm cùng nhau [C1]
7. Nhịp sống		●	●●	●●	Không làm việc quá 55 giờ/tuần; thói quen số lạnh [C1-C2]

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Môi trường: Thân ●, Khí ●●, Tâm ●●, Thần ●). Đề xuất xem xét nâng **Thần lên ●●** nhờ cơ chế 3, 6, 7 (ánh sáng, kết nối, nhịp sống ảnh hưởng mạnh đến giấc ngủ và sự sáng suốt).

Môi trường điều chỉnh năm trụ còn lại

Tín hiệu môi trường	Trụ bị điều chỉnh	Điều chỉnh
Nắng nóng	Luyện tập, Ăn uống, Ngủ nghỉ	Tập trong nhà, giảm cường độ; bù nước, món mát; phòng ngủ mát
Rét đậm	Luyện tập, Ăn uống	Tập khi trời ấm, khởi động kỹ; món ấm (qua lọc thể chất)
Nồm ẩm	Ăn uống, Luyện tập	Bớt đồ sống lạnh, ngọt béo (thấp khốn Tỳ, C3); vận động trong nhà cho ra chút mồ hôi
AQI xấu	Luyện tập, Thiền	Chuyển sang trong nhà; không tập thở sâu ngoài trời
Tiếng ồn, không gian chật	Thiền, Ngủ nghỉ	Bài thiền ngắn, có âm thanh nền; nút tai, rèm
Làm ca đêm	Ngủ nghỉ, Ăn uống	Lộ trình giờ ngủ, giờ ăn riêng
Sống một mình, ít kết nối	Cảm xúc	Tăng gợi ý kết nối, theo dõi tâm trạng sát hơn

Theo lý luận mục V: Môi trường **đổi mục tiêu và lời khuyên, không trừ điểm** của người dùng.

Môi trường tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Môi trường → Ngủ nghỉ	Ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, công việc	C1-C2
Môi trường → Luyện tập	Khí hậu, ô nhiễm, công viên, bạn tập	C1-C2
Môi trường → Ăn uống	Môi trường thực phẩm (quán ăn nhanh, đồ ngọt), bữa cơm gia đình, văn hoá nhậu	C2
Môi trường ↔ Cảm xúc	Kết nối nâng đỡ; xung đột gây căng thẳng; thiên nhiên giảm căng thẳng	C1-C2
Môi trường → Thiền	Không gian yên tĩnh, thiên nhiên hỗ trợ thực hành	C2

Đo lường trụ Môi trường 📏

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng. Phần lớn dữ liệu môi trường tự nhiên **lấy tự động**, không bắt người dùng nhập.

Tự động (nếu người dùng cho phép vị trí)

- **Thời tiết:** nhiệt độ, chỉ số nóng, độ ẩm, rét đậm.
- **AQI** tại khu vực.
- **Tiết khí** hiện tại và miền.
- Thời gian màn hình (nếu điện thoại cho phép).

Một lần, cập nhật khi thay đổi

- **Hồ sơ môi trường** 🏠: nơi ở (thành thị, nông thôn, miền), loại nhà, kiểm tra nhà ở (không khí, ẩm mốc, chỗ ngủ, an toàn), sống với ai, loại công việc (văn phòng, ngoài trời, ca đêm). Hồ sơ này **chỉ dùng để điều chỉnh lời khuyên**.

Check-in hằng tuần

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Tuần này bạn ở ngoài trời, gần thiên nhiên khoảng bao lâu?	<30 phút · 30-60 · 1-2 giờ · >2 giờ	5
2	Tuần này bạn có gặp gỡ, trò chuyện thật lòng với ai không?	Không · 1-2 lần · Nhiều lần	6
3	Tuần này bạn làm việc khoảng bao nhiêu giờ?	<40 · 40-48 · 48-55 · >55	7

Định kỳ (cần chuyên gia chọn công cụ đã thẩm định tiếng Việt)

- Thang cô đơn rút gọn 3 câu (UCLA-3) mỗi 4-12 tuần.

Không đo

- Không theo dõi vị trí liên tục, không lưu lịch sử di chuyển.
- Không thu danh bạ, không phân tích tin nhắn để "đo kết nối".

An toàn riêng cho trụ Môi trường

Bổ sung vào mục X của lý luận. Cần bác sĩ, chuyên gia sức khoẻ môi trường và công tác xã hội duyệt.

Cờ đỏ khẩn cấp

Tình huống	Hành động
Suối bằng than, bếp than tổ ong trong phòng kín; đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ nhiều người cùng lúc	Nghi ngờ độc khí CO: ra chỗ thoáng ngay, gọi 115. Mùa rét miền Bắc cần cảnh báo chủ động: không đốt than trong phòng kín
Lú lẫn, ngừng ra mồ hôi, da nóng khi trời nắng nóng	Nghi sốt nhiệt: làm mát, gọi 115
Người cao tuổi ngã, không tự đứng dậy được	Gọi người thân hoặc 115
Đang bị bạo lực gia đình, bị đe dọa an toàn	Hiển thị số 113 và đường dây hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình đã được xác minh

Cờ đỏ cần đi khám, hỗ trợ

Dấu hiệu	Hành động
Ho, khó thở, khò khè tăng khi ô nhiễm hoặc nấm ẩm	Khuyến đi khám (hen, bệnh phổi)
Cô đơn nặng kéo dài, cô lập hoàn toàn, kèm tâm trạng thấp	Nối cờ đỏ trụ Cảm xúc; khuyến gặp chuyên gia; gợi ý nguồn hỗ trợ cộng đồng
Dấu hiệu kiệt sức nghề nghiệp kéo dài	Khuyến gặp chuyên gia; gợi ý trao đổi với nơi làm việc nếu an toàn

Khoá và điều chỉnh

Nhóm	Điều chỉnh
Người cao tuổi, trẻ nhỏ trong nhà	Ngưỡng cảnh báo nắng nóng, rét đậm, AQI thấp hơn (cảnh báo sớm hơn)
Bệnh tim mạch, hô hấp (hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)	Như trên; ưu tiên ở trong nhà khi thời tiết, không khí xấu

Nhóm	Điều chỉnh
Thai kỳ	Tránh khói thuốc, khói than, hoá chất; cảnh báo nắng nóng sớm hơn
Lao động ngoài trời	Lời khuyên khả thi (ngủ bóng râm, bù nước theo giờ); không khuyến "ở trong nhà" khi không làm được

Lộ trình tiệm tiến gợi ý

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Hồ sơ	Hoàn thành hồ sơ môi trường; bật thời tiết và AQI (nếu muốn)
2	Thanh khí	Kiểm tra không khí trong nhà; sửa một việc dễ nhất (không hút thuốc trong nhà, mở cửa khi thấp hương, bật hút mùi khi nấu)
3	Ánh sáng	Đón nắng sáng; quy tắc 20-20-20
4	Thiên nhiên	Cộng dồn 120 phút gần thiên nhiên trong tuần
5	Nhân hoà	Một lời hỏi thăm; một bữa cơm cùng nhau không điện thoại
6	Nhịp sống	Tắt thông báo không cần; một buổi không màn hình
7-12	Tĩnh âm, nơi ở	Góc yên tĩnh; kiểm tra chỗ ngủ, an toàn nhà ở; tham gia một nhóm cộng đồng

Hai lối vào theo bốn tầng:

- Người **mệt mỏi, hay ốm vặt** (Thân, Khí yếu): bắt đầu từ cơ chế 1, 2 (khí hậu, không khí).
- Người **căng thẳng, cô đơn** (Tâm, Thần yếu): bắt đầu từ cơ chế 5, 6 (thiên nhiên, kết nối).

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

- Đối chiếu nguyên văn: *Bảo mệnh toàn hình luận, Linh Khu "Bản thân", Dị pháp phương nghi luận, Thích pháp luận* (chính khí tồn nội), *Tứ khí điều thần đại luận, Tý luận*.
- Lục dâm trong khí hậu Việt Nam (thử, thấp, hàn; mùa nồm miền Bắc, mùa mưa miền Nam); bộ điều chỉnh tiết khí cho miền Nam.

Bác sĩ, chuyên gia sức khỏe môi trường:

- Ngưỡng cảnh báo nắng nóng, rét đậm, AQI cho người Việt và cho nhóm nguy cơ; nguồn dữ liệu AQI tin cậy.
- Khuyến nghị về khói hương, bếp than, máy lọc không khí, khẩu trang.

3. Cảnh báo ngộ độc CO mùa rét.
4. Số liệu mới nhất về ô nhiễm không khí ở các đô thị Việt Nam.

Chuyên gia tâm lý, công tác xã hội:

1. Thang cô đơn bản tiếng Việt; gợi ý kết nối phù hợp văn hoá; nguồn hỗ trợ cộng đồng.
2. Đường dây hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình đã xác minh; quy trình an toàn khi người dùng có thể đang bị giám sát điện thoại.

Pháp lý:

1. Thu và xử lý dữ liệu vị trí, dữ liệu về quan hệ gia đình.